SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

HASTANE DENETİM REHBERİ

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2009

HİZMETE ÖZEL

ÖNSÖZ

Sosyal güvenlik reformu kapsamında sağlanan uygulama birlikteliğiyle sağlık hizmetlerinin temininde önemli bir iyileştirme hayata geçirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımız tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğiyle, sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere Kurum ile sözleşmesi bulunan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilme imkanı getirilmiş, hastaların ilaçlarını doğrudan sözleşmeli eczanelerden temin etmeleri sağlanmıştır.

Bu noktada sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması, hizmetin nitelik ve niceliğinin artması nedeniyle sağlık giderlerinde artış olmuştur. Sağlık giderlerindeki bu artış tabiidir. Ancak sağlık giderlerinin çeşitli usulsüzlüklerle arttırılması ile de mücadele edilmektedir.

Sağlık suiistimalleri ile mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin sağlık suiistimalleri ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek adına başta Kurumumuz ile sözleşme yapan ve/veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti aldığı sözleşmesiz hastanelerde yapılacak sağlık hizmet alımı incelemelerine ilişkin usul ve esaslara yer verilen Hastane Denetim Rehberinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapma işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi de amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Sağlık suiistimalleri ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Sağlık suiistimalleriyle mücadelede etkin ve caydırıcı denetim sistemi kurma hedefine ulaşacak olan Başkanlığımız, Hastane Denetim Rehberini; Kurumumuz ile sözleşme yapan ve/veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti aldığı sözleşmesiz hastanelerde yapılacak sağlık hizmet alımı incelemelerinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere sağlık suiistimalleriyle mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

Sunuş..... i
İçindekiler..... iii

BÖLÜM 1
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç 1
2. Kapsam..... 1
3. Dayanak..... 1
4. Tanımlar..... 1

4.1. Denetim Rehberi'nin Kullanımı Açısından Önemli Kavramlar: 2

4.1.1. Denetim 2
4.1.2. Denetim Alanı..... 2
4.1.3. Denetim Amacı (Konusu)..... 2
4.1.4. Denetim Gerekçesi..... 2
4.1.5. Denetim Planı..... 3
4.1.6. Denetim Stratejisi..... 3
4.1.7. Riskli Nokta..... 3
4.1.8. Risk Analizi..... 3

4.2. Hastane İle İlgili Temel Kavramlar:..... 4

4.2.1. Sağlık..... 4
4.2.2. Sağlık Hizmeti..... 4
4.2.3. Sağlık Hizmeti Sunucusu..... 4
4.2.4. Sağlık Kurumu ve Kuruluşları..... 4
4.2.5. Hastane..... 7
4.2.6. Hastanede Yer Alan Temel Birimler..... 8
4.2.6.1. Poliklinik..... 8
4.2.6.2. Servis..... 8
4.2.6.3. Klinik..... 8
4.2.6.4. Acil Servis..... 9

4.2.6.5. Yoğun Bakım..... 9
4.2.6.6. Ameliyathane..... 9
4.2.7. Hastane Yönetimi..... 9
4.2.8. Başhekim..... 10
4.2.9. Mesul Müdür..... 11
4.2.10. Hekim..... 10
4.2.10.1. Şef..... 10
4.2.10.2. Şef Yardımcısı..... 11
4.2.10.3. Başasistan..... 12
4.2.10.4. Uzman..... 13
4.2.10.5. Asistan..... 13
4.2.10.6. Pratisyen Tabip..... 13
4.2.11. Hemşire..... 13
4.2.12. Yardımcı Sağlık Personeli..... 13

4.3. Genel Olarak Bilinmesinde Fayda Olan Kavramlar : 14

4.3.1. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)..... 14
4.3.2. Bütçe Uygulama Tebliği (BUT)..... 14
4.3.3. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 14
4.3.4. Sözleşme..... 15
4.3.5. Protokol..... 15
4.3.6. Hizmet Basamağı..... 16
4.3.7. Sevk Zinciri..... 16
4.3.8. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu..... 17
4.3.9. Hasta..... 18
4.3.10. Hasta Dosyası..... 18
4.3.11. Hasta Tabelası..... 20
4.3.12. Epikriz..... 20
4.3.13. Ameliyat..... 20
4.3.14. İşlem Grubu..... 20
4.3.15. Ameliyat Raporu..... 21
4.3.16. Ameliyathane Kayıtları..... 21
4.3.17. Teşhis (Tanı)..... 21
4.3.18. Tedavi..... 21
4.3.19. İlaç..... 23
4.3.20. Beşeri Tıbbi Ürün..... 23
4.3.21. Protez..... 23
4.3.22. Ortez..... 23

4.3.23. İyileştirici Nitelikteki Sıhhi Sarf Malzemesi..... 23
4.3.24. İyileştirme Vasıtası..... 23
4.3.25. Takip No..... 24
4.3.26. MEDULA..... 24

5. GSS Uygulamaları İçinde Hastanelerin Yeri ve Önemi..... 24
6.SGK-Hastane İlişkileri Sistemi 25

6.1. Protokol ve Antlaşmaların İmzalanması..... 26
6.2. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Faturalanması Ve Ödenmek Üzere Kurumumuza Gönderilmesi..... 29
6.3. Gönderilen Faturaların Örnekleme Yolu İle Kontrolü..... 29
6.4. Satın Alınan Sağlık Hizmetlerinin Bedellerinin Ödenmesi 30

BÖLÜM 2

HASTANE DENETİMLERİNDE YARARLANILACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

2.1. Kanunlar..... 33
2.2. Tüzükler..... 34
2.3. Yönetmelikler..... 34
2.4. Tebliğler..... 38
2.5. Bakanlar Kurulu Kararları..... 39
2.6. Genelge ve Genel Yazılar..... 40
2.7. Duyurular..... 43

BÖLÜM 3

HASTANE DENETİM SÜRECİ

3.1. Amaç, Genel İlkeler ve Yöntem..... 45
3.1.1. Amaç..... 47
3.1.2. Genel İlkeler..... 47
3.1.3. Yöntem..... 53
3.1.3.1. Fatura Odaklı Denetim..... 53
3.1.3.2. Tıbbi İşlem Odaklı Denetim..... 54
3.1.3.3. Sayı Odaklı Denetim..... 55
3.1.3.4. Branş Odaklı Denetim..... 56
3.1.3.5. Hasta Dosyası Üzerinden Denetim..... 57
3.1.3.6. Konu Odaklı Denetim..... 58
3.1.3.7. Mevzuat Odaklı Denetim..... 59
3.1.3.8. Çapraz Sorgulamalar..... 59

3.2. Ön Hazırlık ve Denetim Stratejisinin Belirlenmesi..... 61
3.3. Genel Bilgilerin Temini..... 63
3.4. Tıbbi ve İdari Birimler Hakkındaki Bilgilerin Temini..... 65
3.5. Fatura ve Kesintiler Hakkında Bilgilerin Temini..... 66
3.6. Hastane Denetimlerinde Kurum Bilgi İşlem Sisteminden Yararlanma..... 66
3.6.1. Karşılaşılan Zorluklar..... 66
3.6.2. Dikkat Edilecek Hususlar..... 69
3.6.3. Başvurulacak Birimler..... 71
3.6.4. Faydalanılabilecek Bilgi İşlem Sistemleri..... 72
3.6.4.1. MEDULA..... 72
3.6.4.2. GSS Sağlık Kontrol Sistemi (Eczane)..... 74
3.6.4.3. Veri Ambarı 75
3.7. Tıbbi Birim Denetimlerinde Dikkat Edilecek Hususlar.... 75
3.7.1. Genel Suiistimaller..... 75
3.7.2. Kardiyoloji..... 76
3.7.3. Kardiyovasküler Cerrahi (KVC)..... 78
3.7.4. Ortopedi ve Travmatoloji..... 79
3.7.5. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi..... 80
3.7.6. Beyin Cerrahi..... 81
3.7.7. Diş Hastalıkları..... 81
3.7.8. Nefroloji-Diyaliz..... 82

3.8. İdari Birim Denetimlerinde Dikkat Edilecek Hususlar..... 82
3.9. Bilgi İşlem Verilerinin Analizinde Dikkat Edilecek Hususlar..... 85
3.10. Denetim Esnasında Yararlanılabilecek Çapraz Sorgulamalar..... 88
3.10.1. Vefat Tarihinden Sonraki Tarihlerde Tıbbi İşlem Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması..... 90
3.10.2. 2007 SUT' a Göre EK-5/A ve EK-5/C Listelerinde Yer Alan Malzemelerin Fiyatlandırılması..... 91
3.10.3. Hazine Kesintisinin Hatalı Alınması..... 91
3.10.4. SHÇEK Kesintisinin Hatalı Alınması..... 91
3.10.5. Bazı Testler Negatif Olduğu Halde Doğrulama Testlerinin Fatura Edilmesi..... 92
3.10.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları..... 92
3.10.7. MEDULA Sistemindeki Bazı İşlemlerdeki Kısıtlama Aksaklıkları..... 94
3.10.7.1. Bir Hastada Sadece Bir Kez Faturalanabilecek İşlemler 94
3.10.7.2. Günde Bir Kez Faturalanabilecek İşlemler..... 94
3.10.8. Kız Çocuklarının Analık Yardımlarından Faydalandırılmaları 96
3.11. Denetim Esnasında Soruşturma Gerektiren Hususların Tespiti Halinde Dikkat Edilecek Hususlar..... 97
3.12. Denetimlerde Uyulacak Diğer Usul ve Esaslar..... 99

BÖLÜM 4

RAPORLAMA

4.1. Raporlamaya Hazırlık Aşaması..... 101
4.2. Raporlarda Bulunması Gerekli Hususlar..... 107
4.2.1. İnceleme Raporları 107
a) Giriş..... 107
b) Yapılan İnceleme ve Araştırmalar..... 107

c) Alınan İfadeler..... 107
d) Konunun Değerlendirilmesi..... 107
e) Sonuç ve Kanaat Bölümü..... 108
4.2.2. Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar 109
a) Giriş..... 109
b) Yapılan İnceleme ve Araştırmalar..... 109
c) Alınan İfade ve Savunmalar..... 109
d) Konunun Değerlendirilmesi..... 110
e) Sonuç ve Kanaat..... 110

4.3. Rapor Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar..... 111

BÖLÜM 1

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, 5510 sayılı Kanun ve Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde hizmet satın alınan hastanelerde yapılacak, sağlık hizmet alımı incelemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapan ve/veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti aldığı sözleşmesiz hastanelerde yapılacak sağlık hizmet alımı incelemelerini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

Hastane denetimleri esnasında rehberin kullanımı açısından bilinmesine ihtiyaç duyulacak kavramlar aşağıda sıralanmıştır.

4.1. Denetim Rehberi'nin Kullanımı Açısından Önemli Kavramlar:

4.1.1. Denetim: Türk kamu yönetimi literatüründe "teftiş", "murakabe", "kontrol" gibi kavramlarla özdeşleşen farklı tanım ve anlamları olmakla birlikte, bu rehberde "sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler ile genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişelerin sağlık hizmeti aldığı sözleşmesiz hastaneler hakkında yapılan inceleme ve soruşturma işlemleri" anlamında kullanılmıştır.

4.1.2. Denetim Alanı: Denetim gerekçesinde yer alan bilgilere göre müfettiş tarafından denetlenmeye değer bulunan ya da denetimi zorunlu görülen, anlam yönünden bir bütünlük arz eden denetim konularıdır.

"Herhangi bir hastane tarafından düzenlenerek Kurumumuza gönderilen faturalarda Kurum zararına yol açılıp açılmadığının incelenmesi" şeklindeki genel bir denetim gerekçesine göre inceleme yapacak olan bir müfettişin denetim alanı *"kardiyoloji işlemleri, malzeme işlemleri, hasta dosyalarının tanzimi, vb."* olabileceği gibi, *"hastane tarafından düzenlenen tüm faturalar"* da olabilir. Yine, *"herhangi bir hastanenin doktoru tarafından düzenlenen ameliyat raporlarının sahteliğinin araştırılması"* şeklindeki özel bir denetim gerekçesine göre soruşturma yapacak olan bir müfettişin denetim alanı ise *"adıgeçen hekim tarafından düzenlenen ameliyat raporları ve temin edilen menfaatin boyutu"* olacaktır.

4.1.3. Denetim Amacı (Konusu): Denetim gerekçesinde ortaya konulması, açıklığa kavuşturulması, çözüm ve öneri getirilmesi ya da uygulanacak yaptırımların gerekçelerinin belirtilmesi istenilen tüm hususlardır.

4.1.4. Denetim Gerekçesi: İlgili müfettişe gönderilen ve Bakan, Kurum Başkanı veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca onaylanan hastaneler ile özel dal ve tıp merkezleri hakkındaki görev emri ve eki belgelerdir.

4.1.5. Denetim Planı: Denetime fiilen başlamadan önce ilgili müfettiş ya da müfettişlerce yapılan; "denetimde nasıl bir yöntem izleneceği, hangi bilgi ve belgelerin toplanması gerektiği, bunun için hangi bilgilere ve kayıtlara müracaat edilebileceği, gerekli görülürse kimlerin ifadesine başvurulabileceği, konunun hangi açılardan ele alınarak irdeleneceği ve kapsamının nasıl sınırlandırılacağı, denetim esnasında yapılacak işlerin hangi sırada yapılacağı, hangi faaliyetin ne kadar sürede yapılacağı, birden fazla müfettiş tarafından yürütülecek işlerde iş bölümü yapılmasının mümkün olup olmadığı, mümkün ise kimin hangi konuların denetiminden sorumlu olacağı, bilirkişi incelemesine ihtiyaç bulunup bulunmadığı, raporlamanın nasıl yapılacağı, muhtemel durumlara göre ne tarzda hareket edileceği" gibi hususlarda karar verilmesini sağlayan ve bunları belirgin hale getiren plandır.

4.1.6. Denetim Stratejisi: Denetimde görevli müfettiş ya da müfettişlerce denetim esnasında izlenmesi uygun görülen yoldur. Denetim stratejisinin; denetim esnasında faydalanılabilecek güçlü yanlar ile denetimi zorlaştıracak zayıf yanları da içeren sağlıklı bir durum analizine, belirgin ve uygulanabilir bir denetim planına ve denetim faaliyetlerinin denetim amacıyla ilişkisini devamlı olarak sağlayacak nitelikte bütüncül bir yaklaşıma dayanması gereklidir.

4.1.7. Riskli Nokta: Konu ile ilgili mevzuat, kullanılan manüel ve elektronik tabanlı sistemler, uygulanmakta olan denetim prosedürleri, uygulayıcı personel vb. yönlerden var olan eksiklik ya da aksaklıklar nedeni ile Kurumumuz aleyhine sonuçlar doğurması muhtemel olan ve denetlenmesi halinde bu durumun giderilebileceği tahmin edilen denetim alanlarıdır.

4.1.8. Risk Analizi: Denetimde görevli müfettiş ya da müfettişlerce riskli noktaların ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacı ile yürütülen; mevzuat analizi, bilgi işlem sistemlerinin incelenmesi, personelden uygulamalar hakkında bilgi alınması, kullanıcı hatalarının engellenmediği bilgi işlem uygulamalarının tespiti gibi faaliyetlere dayanan ve denetim planına somut bir dayanak sağlayan faaliyetlerdir.

4.2. Hastane İle İlgili Temel Kavramlar:

4.2.1. Sağlık: Yalnız hastalık ve malûliyetin yokluğu olmayıp; bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir (224 sayılı Kanun/Md.2).

4.2.2. Sağlık Hizmeti: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması (rehabilitasyon) için yapılan tıbbi faaliyetlerdir (224 sayılı Kanun/Md.2).

4.2.3. Sağlık Hizmeti Sunucusu: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile basamaklandırılamayan sağlık kuruluşlarının yanında; optisyenlik müesseseleri, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri ve kaplıcaların da dâhil olduğu, 5510 sayılı Yasa kapsamında Kurumumuzla hizmet sunumu, faturalama ve ödeme ilişkisine giren tüm gerçek ve tüzel kişilerdir[1].

4.2.4. Sağlık Kurumu ve Kuruluşları: Resmi ya da özel tüzel kişiliklere ya da gerçek kişilere ait olup ayakta veya yatarak teşhis, tetkik ve tedavi hizmeti sunan yataklı ve yataksız sağlık tesisleri ve laboratuarları, muayenehaneleri, kaplıcaları, aile hekimlerini, kurum hekimliklerini, Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimlerini ve serbest eczaneleri ifade eder[2]. Mülkiyet biçimlerine, verilen hizmet şekline ve bulundukları hizmet basamağa göre sınıflandırılabilirler. (Bakınız Sağlık Uygulama Tebliği)

a) *Sağlık kurum ve kuruluşları, mülkiyet şekillerine göre; resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları şeklinde ayrılabilir*[3].

Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık

[1] Bu hususta ilgili yılın sağlık uygulama tebliğinde yapılan tanımlar da gözden geçirilmelidir.
[2] Bu hususta ilgili yılın sağlık uygulama tebliğinde yapılan tanımlar da gözden geçirilmelidir.
[3] Bu hususta ilgili yılın sağlık uygulama tebliğinde yapılan tasnifler de gözden geçirilmelidir.

merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birinci basamak sağlık üniteleri, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezi ve dal merkezleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, vakıflara ait eğitim ve araştırma hastaneleridir.

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulmuş, yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi amacıyla hasta kabul eden Sağlık Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş sağlık kurum ve kuruluşlarını ifade eder. "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında açılan tıp merkezleri ve özel poliklinikler ile aynı yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal merkezleri, "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları, 'Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış hastaneler ve serbest eczaneler bu grupta sayılır. (Bakınız Sağlık Uygulama Tebliği)

b) *Sağlık kurum ve kuruluşları, verilen hizmetin şekline göre; ayaktan ve yatarak tedavi kurum ve kuruluşları şeklinde ayrılabilir.*

Ayaktan Tedavi Kurum ve Kuruluşları: Hasta yatırılmaksızın tetkik, teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşlarıdır. Dispanserler, özel tıp merkezleri, özel poliklinikler, tetkik merkezi ve laboratuarlar, ağız ve diş sağlığı merkezleri bu gruba örnek olarak verilebilir.

Yataklı Tedavi Kurum ve Kuruluşları: Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır (YTKİY/Md.4). Genel ve özel dal hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri bu gruba örnektir.

c) *Sağlık kurum ve kuruluşları, bulundukları hizmet basamağına göre; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları şeklinde ayrılabilir.*

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hizmet basamakları ve basamaklara dâhil edilecek hastaneler şu şekilde sıralanabilir[4];

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları: Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında açılan özel poliklinikler, "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık kuruluşları bu kapsamdadır.

İkinci Basamak Sağlık Kurumları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezi ve dal merkezleri, Özel Hastaneler

---

[4] Bu hususta ilgili yılın sağlık uygulama tebliğinde yapılan tasnifler de gözden geçirilmelidir.

Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal merkezleri.

Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları: Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, vakıflara ait eğitim ve araştırma hastaneleri.

4.2.5. Hastane: Yataklı sağlık hizmeti verilen sağlık kurum ve kurumlarıdır. Hastaneler de mülkiyetlerine ya da verilen sağlık hizmetinin mahiyetine göre tasniflenebilirler.

a) *Hastaneler, mülkiyet şekillerine göre; resmi ve özel hastaneler şeklinde ayrılabilir.*

Resmi hastaneler; Sağlık Bakanlığına, mahalli idarelere, üniversitelere, mazbut vakıflara ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hastanelerdir.

Özel hastaneler; Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamına giren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbî müdahale, ameliyat, tıbbî bakim ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarıdır. Adıgeçen yönetmelikle; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerine ait tüm hastanelerin, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, sınıflandırılmasına, sınıflarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir.

b) *Hastaneler, verilen sağlık hizmetinin mahiyetine göre; genel dal, özel dal, eğitim ve araştırma hastaneleri şeklinde ayrılabilirler.*

Genel Dal Hastaneleri; her türlü acil vak'a ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı hastanelerdir.

Özel Dal Hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı, doğumevleri, göğüs hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk sağlığı, meslek hastalıkları hastaneleri gibi hastanelerdir.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri: Sağlık Bakanlığınca uzman tabip yetiştirmek üzere yetki verilen ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Yönetmeliği çerçevesinde eğitim veren hastanelerdir. Üniversite hastaneleri de bu grupta sayılabilir.

4.2.6. Hastanede Yer Alan Temel Birimler:

4.2.6.1. Poliklinik: Ayaktan teşhis, tetkik ve tedavi hizmeti verilen birimlerdir.

4.2.6.2. Servis: Hastaların yatarak tedavi gördükleri, belli bir tıbbi branşta (Koroner Yoğun Bakım, Ortopedi, Genel Cerrahi gibi) uzmanlaşmış hekimlerin çalıştığı birimlerdir. İdari yapılanma açısından laboratuar, MR, Acil Servis gibi birimler de birer servis sayılırlar.

4.2.6.3. Klinik: Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde kurulan ve belli bir tıbbi branşta (Koroner Yoğun Bakım, Ortopedi, Genel Cerrahi gibi) uzmanlaşmış hekimlerin çalıştığı, hastalara yataklı tedavi hizmeti sunulmasının yanında tıbbi araştırmalar ve tıp eğitimi de verilen birimlerdir.

4.2.6.4. Acil Servis: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlarla ilgili olarak sağlık hizmeti verilen servislerdir.

4.2.6.5. Yoğun Bakım: Hekim ve hemşire hizmetleri ile diğer teknik, sağlık ve laboratuar hizmetleri bakımından sürekli olarak gözlem ve kontrol altında bulundurulması gereken hayati tehlike içindeki hastaların, bakımlarının sağlandığı yataklı bakım üniteleridir (YTKİY/Md.16).

4.2.6.6. Ameliyathane: Cerrahi işlemlerin yapıldığı ve özel donanıma sahip birimler olup işlemin niteliğine göre genel anestezi, spinal anestezi ya da lokal anestezi ile işlem yapılan büyük girişimsel ya da küçük girişimsel ameliyathaneler şeklinde teşekkül ettirilebilirler.

4.2.7. Hastane Yönetimi: Üçüncü şahıslara karşı hastaneyi temsilden ve hastanenin idaresinden genel olarak sorumlu bulunan kişilerdir. Resmi hastanelerde görev ayrımına göre baştabip, başhemşire ve hastane müdürü ile yardımcıları; özel hastanelerde ise mesul müdür ile mesul müdür yardımcısı hastane yönetimi olarak kabul edilir. Denetimlerde tespit edilen tüm aksaklıklardan genel olarak bu kişilerin sorumlu oldukları kabul edilir.

Denetim konusu özel durumlar ile TCK açısından suç teşkil eden eylemlerin tespiti amaçlı denetimlerde, denetime konu kişilerin (hastanenin sahip ve ortakları ya da yönetim kurulu üyeleri, doktor, eczacı, hemşire, diğer idari birim sorumluları, vb.) şahsi kasıt ve kusuru ile ilgili değerlendirmeler bu durumun dışındadır.

Özel hastanelerde, hastanenin sahip ve ortakları ya da yönetim kurulu üyeleri de idari ve mali yönlerden hastanenin tüm işlemlerinden genel olarak sorumludurlar.

4.2.8. Başhekim: Resmi hastanelerde mevcut olan bir kadro unvanı olup, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 110. maddesine göre;

- Eğitim ve araştırma hastaneleri; servis ve laboratuar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör tabipler arasından Sağlık Bakanlığınca atanacak başhekimler tarafından,

- Diğer hastaneler ise; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak başhekimler tarafından yönetilir.

Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığı'na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 5. maddesinde sayılan hastaneler açısından bağlayıcıdır.

4.2.9. Mesul Müdür: Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre, özel hastanelerin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerinin sorumluluğunu taşıyan ve bu hizmetlerin yürütülmesini sağlayan kişidir. Mesul Müdür'ün;

a) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye'de sanatını yapmaya mezun olması,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

c) Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgelerin bulunması,

d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapse mahkum veya 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'nun 38. ve 39. maddeleri uyarınca mesul müdürlükten yasaklı olmaması,

e) İlgili tabip odasına kayıtlı olması,

gereklidir.

Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar.

4.2.10. Hekim: İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimsedir (TDK/Büyük Türkçe Sözlük). Bu mesleğin genel şartları 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı (hekimlik mesleği ve branşları) San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da düzenlenmiştir.

Kanun'a göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hekimlik yapmak ve hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye üniversitesi tıp fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk olmak şarttır. Bu diplomanın güvenilir olması için mecburi hizmetini ikmal etmiş ve diplomasının Sağlık Bakanlığınca tasdik ve tescil edilmiş olması lazımdır. Ancak mecburi hizmetlerini ifa ettikleri müddetçe diplomaları alıkonulan hekimler bu müddet zarfında bile sanatlarını icra etme hakkında sahiptirler.

Özel muayenehane açmak veya evinde muayenehane kurmak suretiyle sanatını icra etmek isteyen her hekim, hasta kabulüne başladığı andan itibaren en çok bir hafta içinde; isim ve hüviyetini, diploma tarih ve numarasını, muayenehane kabul ettiği yer ile mevcut ise uzmanlık evrakını mahallin en büyük sağlık memuruna kaydettirmeye ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel bu durumu bildirmeye mecburdur. Aynı şekilde bir yerde sanatını icra eden kayıtlı bir tabip o yeri terk ettiği veya her ne bir sebeple olursa olsun muayenehanesini kapatarak sanatını icradan vazgeçtiği takdirde, bu işlemden en az yirmi dört saat evvel evvelce kaydedilmiş olduğu sağlık dairesine müracaatla kaydettirir.

Türkiye'de hekimlik yapabilmek için kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar genel surette hastalıkları tedavi hakkına sahiptirler. Ancak her hangi bir tıbbi branşta sürekli uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için; Türkiye Tıp Fakültesi'nden veya Sağlık Bakanlığınca kabul ve ilan edilecek kurumlardan verilmiş yahut yabancı ülkelerin bilinen bir hastane veya laboratuarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir uzmanlık vesikasına sahip olmak gerekir.

Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir hekimin bizzat dükkan ve mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması yasaktır. Ancak, kanuna uyarak müsaade almak suretiyle özel hastane açması veya aynı zamanda eczacılık diplomasını haiz olan bir hekimin hekimlik mesleğini icra hakkından feragat etmek ve iki yıl bir eczanede uygulama görmüş olduğuna dair belge ibraz etmek şartıyla eczane açarak idare etmesi bu hükmün dışındadır. Bir tabibin, ikametgâhı istisna olmak üzere, birden fazla yerde muayenehane açarak sanatını icra etmesi yasaktır.

Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler (6023 sayılı Kanun).

Özel kurum ve işyeri hekimleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetlerince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.

Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'na tabidirler.

Hekimlerin eğitimi ve yetiştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar Tababet Uzmanlık Tüzük ve Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Yönetmelikte yer alan bazı tanımlar aşağıda açıklanmıştır.

4.2.10.1. Şef: Eğitim hastanelerinde sorumlu servis ve laboratuar uzmanlarına şef, diğer Kurumlardaki uzmanlara servis veya laboratuar uzmanı denir.

4.2.10.2. Şef Yardımcısı: Şefe yardımcı olan uzmandır.

4.2.10.3. Başasistan: Şef ve şef yardımcıları yönetiminde asistan yetiştirmeye yardımcı olan uzmandır.

4.2.10.4. Uzman: Tababet Uzmanlık Tüzük ve Yönetmeliği hükümlerine göre gördüğü asistanlık eğitimi sonrasında girdiği uzmanlık sınavında başarılı olarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olan kişidir.

4.2.10.5. Asistan: Kurumlarındaki kadro unvanları ne olursa olsun, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Giriş Sınavı'nda (DUS) başarılı olarak asistanlık hakkını kazanan, tıp veya diş hekimliği uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve özel mevzuat hükümleri çerçevesinde öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama yapmak üzere atanan tıp doktoru veya diş hekimini ifade eder.

Asistanların atanmalarında kurumlarının özel mevzuat hükümleri uygulanır (Tıpta Uzmanlık Tüzüğü/Md.13).

4.2.10.6. Pratisyen Tabip: Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir tıp dalında uzmanlaşmamış hekimlere verilen addır.

4.2.11. Hemşire: 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 1. maddesine göre; Türkiye'de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili ve Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan, diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere "Hemşire" unvanı verilmektedir.

4.2.12. Yardımcı Sağlık Personeli: Hemşireler, ebeler, tıbbi teknisyenler, tıbbi sekreterler, sağlık memurları gibi personel bu gruba dâhildir.

4.3. Genel Olarak Bilinmesinde Fayda Olan Kavramlar:

Bu rehberin 4.3.3 numaralı maddesinde belirtilen kişilere verilecek tüm sağlık hizmetleri ile ilgili esaslar (teşhis, tedavi, sevk, katkı payı vb.) 6 ve 8 Numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğleri, Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No.7) ve Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de (2009-1) belirtildiğinden, yapılacak incelemelerde bu mevzuatın esas alınması gerekmektedir.

4.3.1. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Kapsamı 5510 sayılı Kanun'un 60. maddesinde belirtilen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Kurumumuzca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin olarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen bedellerin bildirilmesi amacıyla çıkarılan tebliğdir.

4.3.2. Bütçe Uygulama Tebliği (BUT): Her yıl çıkarılan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile uygulamaya konulan ve "belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge" olarak tanımlanan bütçenin değişik konularla ilgili uygulama esaslarını gösteren tebliğlerdir. Bu tebliğlerin önemli bir kısmı sağlık hizmetleri ile ilgili olup "Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği" adı altında çıkarılmakta ve Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır.

4.3.3. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği: (2008 TYİUT/Md.1.2) Bütçe uygulamasında tedavi harcamaları ve usulleri ile ilgili düzenlemeler getiren tebliğlerdir. Bu tebliğ;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1. ve ek geçici 9 ile 16. maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı

Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (Erbaş ve erler bu tebliğ hükümleri haricindedir. Erbaş ve er reçeteleri ile ilgili olarak şahıslara mali külfet getirmemek koşuluyla gerekli düzenlemeler Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

c) 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri, (3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla),

hakkında uygulanır[5].

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarında yapılan tedavilerinde de aynı tebliğ esaslarına göre işlem yapılır.

4.3.4. Sözleşme: Kurumumuz ile özel sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık ile ilgili çeşitli alanlarda hizmet alımına ilişkin olarak imzalanan ve tarafları bağlayıcı niteliği bulunan, "sözleşme uygulaması ile ilgili usul ve esasları, ödeme şartları ve zamanı, cezai şartlar, fesih ve uyuşmazlıklarda başvurulacak mahkeme" gibi hususları belirleyen yasal belgedir.

4.3.5. Protokol: Kurumumuz ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan, kapsamındaki kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan "ayakta/yatarak muayene, tetkik, tahlil ve tedavisinin teminine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülükleri" belirleyen yasal belgedir.

---

[5] Kapsam hakkındaki bilgiler hususunda ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğleri de gözden geçirilmelidir.

4.3.6. Hizmet Basamağı: Sağlık hizmetinin sunumunda görev alan sağlık tesisleri arasında sağlık tesisinin büyüklüğü, sunduğu hizmetin kapsamı ve tabi olduğu mevzuata göre yapılan sınıflandırmayı ifade eder. Sağlık Bakanlığınca yapılan bu sınıflandırmaya göre, üç hizmet basamağı belirlenmiştir (Bkz. Sağlık Kurumu ve Kuruluşları).

Sağlık hizmet sunumu bakımından aşağıda yer alan sağlık kurumları/kuruluşları basamaklandırmaya dâhil edilmemiştir:

a) Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,

b) Refik Saydam Hıfzısıhha Laboratuarları,

c) Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuarlar,

d) Muayenehaneler,

e) Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimleri,

Ayrıca; eczaneler, optisyenlik müesseseleri, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri ile kaplıcalar da sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılmaya dâhil edilememektedir.

4.3.7. Sevk Zinciri: Sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki hasta trafiğini düzenlemek, hastalığın türüne göre hastaları doğru hizmet basamağındaki sağlık kurum ve kuruluşlarına yönlendirerek özellikle üst basamaktaki sağlık birimlerinde yığılmaları önlemek amacı ile getirilen, uyulmaması halinde parasal anlamda getirilen yaptırımlarla desteklenen bir hasta sevk planlama modelidir. Son yapılan düzenleme ile aile hekimliği de sisteme dâhil edilmiş olup 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun" kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Kurumca belirlenecek illerde, 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve

tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması zorunludur. Sevk zinciri uygulamasına geçilecek iller ile bu illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinin usul ve esasları Kurumca duyurulmaktadır.

5510 sayılı Kanun'un uygulanması bakımından hizmet basamakları ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir. Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadır

4.3.8. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu:

- 5510 sayılı Kanun'un 65. maddesi gereğince ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye;

- Tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırmaya,

- 5510 sayılı Kanun'un 63. maddesi hükümlerine göre finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devlet'in doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye,

Yetkili bir komisyondur.

Komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı'nı temsilen birer üye ve Kurum'u temsilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmakta olup salt çoğunlukla aldığı kararlar Resmî Gazete'de yayınlanır.

Komisyonun çalışmasına, görev ve yetkileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, üye kurumların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

4.3.9. Hasta: Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız kimsedir (TDK Büyük Türkçe Sözlük).

4.3.10. Hasta Dosyası: Yataklı tedavi hizmeti veren resmi ve özel tüm sağlık tesislerinde tedavi gören her hasta için açılan ve içinde hastanın tedavisi ile ilgili olarak yapılan işlemler ile ilgili belgelerin bulunduğu dosyadır. Hastane yönetim bilgi işlem sistemlerine sahip hastanelerde bu dosyada bulunması gereken belgelerden bazılarının bilgi işlem ortamında tutulması da mümkündür. Bazı hastanelerde sadece yatarak değil ayakta tedavi hizmeti alan hastalar için de hasta dosyası açıldığı görülmektedir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 48. maddesine göre; özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahedeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır.

Hasta dosyası içerisinde, asgarî olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:

a) Hasta kabul kâğıdı,

b) Tıbbî müşahede ve muayene kâğıdı,

c) Hasta tabelası,

d) Derece kâğıdı,

e) Röntgen istek kâğıdı ve tetkik raporları,

f) Laboratuar istek kâğıdı ve tetkik raporları,

g) Ameliyat kâğıdı,

h) Hastanın muayene istek formu,

ı) Çıkış özeti,

i) Ameliyatla hastanın vücudu içine yerleştirilen iyileştirici tıbbi malzeme ve endoproteze ait sticker/barkodlar,

j) 01/08/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca alınmış ve uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair rızayı gösteren muvafakat formu.

Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre; Yönetmelik'te belirtilmiş her türlü kayıt işleminin bilgisayar ortamında ve/veya ihtiyaca göre yazılı kayıt sistemi ile tutulması mümkündür. Bu amaçla, bilgisayar çıktılarının sistem dâhilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması, bilgisayar ortamındaki kayıtların denetim veya başkaca resmî amaçla istenildiğinde bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi, gizliliğin ihlal edilmemesi amacıyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden Mesul Müdür sorumludur. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere veriler yedeklenir.

Özel hastaneler hasta dosyasında bulunan belgelerden aşağıda belirtilenleri hastalar tarafından istenildiğinde ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf

malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,

b) Adlî vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen filmleri,

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti.

4.3.11. Hasta Tabelası: Hasta dosyasında bulunan ve hastalara verilen ilaçlar, alınan tedbirler, iaşe (yemek) vb. bilgilerin yer aldığı belgedir.

4.3.12. Epikriz: Kelime olarak "hasta çıkış özeti" anlamına gelmekle birlikte, ilgili doktoru tarafından hastanın taburcu olmasından sonra tanzim edilen bir belge olarak "hastalığın tanısı, yapılan operasyon ve sonuçları, taburcu muayene bulguları, öneriler ve benzeri bilgiler yer alan, hastanın bir başka hekim tarafından kontrolü esnasında kolaylık sağlayan" bir rapordur.

4.3.13. Ameliyat: Herhangi bir nedenle yapılan cerrahi işlem, operasyon anlamına gelir (TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü).

4.3.14. İşlem Grubu: Sağlık Uygulama Tebliği ile Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği eklerinde yer alan Paket Fiyat Uygulama Listelerinde yer alan işlemlerin ait olduğu grupları gösteren ve A'dan E'ye kadar olmak üzere 5 kademeden oluşan dereceleme sistemidir. Ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastanın tedavi süresinin aşağıda belirtilen tedavi sürelerini aşması halinde

- A Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra 15 günü,
- B Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra 10 günü,
- C Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra 8 günü,
- D Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra 5 günü,

- E Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra 3 günü,

geçen her bir yatış günü için verilen komplikasyona ilişkin tedavi hizmetlerinin bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilir[6].

Bu derecelendirme aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile yapılan birden fazla ameliyatta hangi işlemin daha yüksek fiyattan fiyatlandırılacağının bilinmesi yönünden de önemlidir.

4.3.15. Ameliyat Raporu: Ameliyat edilen hastalarla ilgili olarak, ameliyat esnasında yapılan işlemlerin, kullanılan malzemelerin ve ameliyatla ilgili önemli görülen diğer hususların kaydedildiği rapordur.

4.3.16. Ameliyathane Kayıtları: Ameliyathanelerde yapılan anestezi işlemleri ve cerrahi işlemler ile ameliyathanenin idari düzenini sağlamak için tutulan anestezi raporu, cerrahi izlem formu, ameliyathane protokol defteri, ameliyat defteri gibi kayıtlardır. Ameliyat defterleri her ameliyathane için bir tane olabileceği gibi ameliyat yapan her doktor için ayrı ayrı da tutulabilir. Bu defterde de işlemi yapan doktor, ameliyat ekibi, kullanılan malzemeler, yapılan işlem ve mahiyeti ile hastanın adı, soyadı, teşhisi gibi bilgiler bulunur.

4.3.17. Teşhis (Tanı): Bir hastalığın öykü alma, muayene etme, radyoloji, laboratuar ve benzeri yöntemler kullanılarak inceleme ve gözlemleme sonucu ayırt edilmesi ve tanımlanmasıdır (Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hk. Yönetmelik/Md.4). Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Uluslararası Hastalık Sınıflaması (ICD 10) Listesi'nde (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) geçerli tüm tanı çeşitleri kodlandırılmış olarak yer almaktadır.

4.3.18. Tedavi: İlaç kullanımı, girişimsel radyoloji ve cerrahi uygulama, öneride bulunma ve benzeri yöntemler ile hastalığı

[6] Bu hususta bilgiler 2008 SUT'a göre derlendiğinden denetimler esnasında ilgili yıl sağlık uygulama tebliğinin esas alınması gerekmektedir.

iyileştirmek, tehlikesini azaltmak ya da yarattığı ızdırabı hafifletmek için yapılan tıbbî uygulamaların tümüdür (Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hk. Yönetmelik/Md.4). 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre tedavi kategorileri şunlardır[7]:

a) **Yatarak tedaviler:** Sağlık kurumlarında yatış tarihinden itibaren taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedavilerdir.

b) **Günübirlik tedavi:** Aşağıda belirtilen ve sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan, 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan tedavilerdir.

Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler;

b.1. Kemoterapi tedavisi,

b.2. Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç),

b.3. Genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz (damar içi) veya inhalasyon (solunum) ile sedasyon (sakinleştirme) gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,

b.4. Diyaliz tedavileri,

b.5 Kan, kan bileşeni, kan ürünü, SUT eki "Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi" nde (EK-2/B) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu, Palivizumab Uygulamasıdır.

3) **Ayaktan tedavi:** Yukarıda açıklanan durumlar dışında kalan ve hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanması, ayaktan tedavi olarak kabul edilir.

---

[7] Bu hususta ilgili yılın sağlık uygulama tebliğinde yapılan tasnifler de gözden geçirilmelidir.

4.3.19. İlaç: Hastalıklardan korunma, teşhis, tedavi veya vücudun herhangi bir fonksiyonunu değiştirmek üzere kullanılacak sentetik, bitkisel veya biyolojik kaynaklı etken madde, terkip ve/veya eczacılık ürünleridir (İlaç Araştırmaları Hk. Yönetmelik).

4.3.20. Beşeri Tıbbi Ürün: Bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojık fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonudur. (Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Md.4)

4.3.21. Protez: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya bir kaçının tam veya kısmi kaybında, o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbî cihazlardır. İşitme cihazları, ağız protezleri, malul arabaları, konuşma cihazları, el- kol- bacak protezleri bu gruba girer.

4.3.22. Ortez: Genel anlamı ile "doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybını veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini desteklemek veya korumak amacıyla kullanılan tıbbî cihazlardır. Ortopedi alanında ise "kemikteki biçim bozukluğunu düzelten, bozukluğun ekleme vereceği yükü azaltan veya felçli kasa destek veren araç" anlamında kullanılır. Koroner damarlara takılan stentler, koltuk değneği, varis çorabı bu gruba örnek olarak verilebilir.

4.3.23. İyileştirici Nitelikteki Sıhhi Sarf Malzemesi: Hastanın herhangi bir rahatsızlığının iyileşmesini sağlayan ya da kolaylaştıran, kullanıldıktan sonra başka bir hastaya kullanılması mümkün olmadığı için bir defa sarf edilebilen malzemelerdir. Fıtık ameliyatları sonrasında karın duvarını güçlendirmek için kullanılan dual meshler, kalp damar cerrahisinde kullanılan greftler (suni damarlar), patch'ler (yama) vb. bu gruba örnektir.

4.3.24. İyileştirme Vasıtası: Geçirilen ya da geçirilmekte olan herhangi bir rahatsızlık sonrası hastanın iyileşmesine yardımcı

olma amacını taşıyan ve geçici bir süre kullanılan malzemelerdir. Kol, dirsek, ön kol, el bileği ve parmakları hastalıklarında, omuz ve oynağı hastalıklarında verilen düzenleyici ve destekleyici ateller bu gruba örnektir.

4.3.25. Takip No: MEDULA tarafından her hasta başvurusu için bir adet olmak üzere üretilen ve her başvuruda yapılan işlemlerin toplu takibini sağlayan numerik ve alfabetik karakterlerin karışımından oluşan bir numaradır. Takip numarası bilindiği takdirde hastanın herhangi bir başvurusu esnasında yapılan tüm işlemler MEDULA ekranından bulunabilir.

4.3.26. MEDULA: MED(ikal) ULA(k) kelimelerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile isimlendirilen, ülke genelindeki Kurum sağlık harcamalarının takibi ve sağlık finansman politikalarının geliştirilebilmesi amacı ile tüm sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti kullanım verisini toplamak ve gerekli geri ödemeleri yapabilmek amacı ile oluşturulan bir bilgi işlem sisteminin genel adıdır.

5. GSS Uygulamaları İçinde Hastanelerin Yeri ve Önemi

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 20.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5502 sayılı Yasa ile kurulmasından önce sosyal güvenlik sistemimizin üç temel ayağını uzun zaman boyunca T. C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu oluşturmuş; sosyal güvenlik hizmetleri kapsamında yer alan sağlık yardımları da bu kurumlar tarafından arz ya da finanse edilmiştir. Bu kurumlardan T. C. Emekli Sandığı ile Bağ-Kur, ilgili kanunları gereğince sağlık hizmeti sunmakla yükümlü oldukları kimselere sağladıkları sağlık hizmetlerini "satın alma" yöntemi ile karşılamayı tercih ederken; Sosyal Sigortalar Kurumu bu yönteme ilave olarak sağlık hizmetlerini bizzat sunabilmek için sağlık tesisleri açıp işletmeyi tercih etmiştir. Ancak, uzun zaman boyunca ülkemizin sağlık sisteminin önemli bir unsuru olan ve sağlık sektörünü yönlendiren bu kurumun bünyesindeki sağlık tesisleri de 5283 sayılı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık

Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun" ile Sağlık Bakanlığı'na devredilince, tüm sosyal güvenlik kurumları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca sağlanan sağlık hizmetlerinin en önemli alıcıları haline gelmişlerdir. Bilahare, 20.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kurulan Kurumumuz da aynı yolu izlemiştir.

Sosyal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmetlerinin satın alma yolu ile karşılandığı tüm ülkelerde ortaya çıkan bir zorunluluk, satın alınan sağlık hizmetini veren kurum ve kuruluşların denetiminin etkili bir biçimde sağlanmasıdır. Bu zorunluluk sadece satın alınan sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve fiyatlarının belli bir düzeyde tutulması isteğinden değil; sağlık sektöründe oluşabilecek yolsuzlukların mali boyutunun önemli miktarlara ulaşabilecek olması karşılanamayacak bir büyüklüğe erişmesinin, kısıtlı kaynakların haksız kişilere, kurumlara ve yanlış sağlık politikalarına harcanmasının önlenmesi ve sonuçta tüm bir sağlık sisteminin çöküşünün engellenmesi amacından da kaynaklanmaktadır. Zira sağlık sektörünün mali büyüklüğü, çeşitli suiistimallerle haksız menfaat temin etmek isteyen kişi, firma, kurum ve kuruluşları da etik anlamda olumsuz etkilemektedir.

Kurumumuz sağlık harcamalarının kontrol altında tutulması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kimselere sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin korunması ve geliştirilmesi ile sağlık sektöründeki yolsuzluklarla mücadele açısından sağlık kurum ve kuruluşları arasında en önemli yeri "hastaneler" teşkil etmektedir. Diğer bir deyişle hastaneler; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin yürütülebilmesi, sağlık harcamalarının kontrol altına alınması, kalite düzeyinin geliştirilmesi ve örnek bir sağlık sisteminin kurulması amaçlarına ulaşma açısından önemli bir alanı oluşturmaktadır.

6. SGK-Hastane İlişkileri Sistemi

Kurumumuz ile hastaneler arasındaki ilişkiler temel olarak;

- 5510 sayılı Yasa kapsamına giren kimselere sağlık hizmeti verilmesi için gerekli protokol ve antlaşmaların imzalanması,

- Sağlık hizmetlerinin sunumu, faturalanması ve ödenmek üzere Kurumumuza gönderilmesi,

- Gönderilen faturaların örnekleme yolu ile kontrolü,

- Satın alınan sağlık hizmetlerinin bedellerinin ödenmesi,

olmak üzere dört başlık altında incelenebilir. Bu başlıklarda yer alan işlemlerin uygulanması ile ilgili düzenlemeler ise; sözleşme ve protokol metinleri, Sağlık Uygulama Tebliğleri ile Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğleri, Kurumumuzca çıkarılan genelge ve genel yazılar ve bunların çerçevesini çizen genel nitelikli mevzuatta yer almaktadır.

6.1. Protokol ve Antlaşmaların İmzalanması:

Kurumumuzca sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alınması işlemleri 5510 sayılı Kanun'un 73. maddesinde tanınan yetkiye dayanarak imzalanan sözleşme ve protokoller dâhilinde yürütülmektedir.

Anılan maddenin birinci fıkrasına göre; sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya Kanun hükümlerine uygun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanmaktadır.

Yine aynı maddenin sekizinci fıkrasında; "Kurum'un, birinci fıkrada belirtilen yöntemler dışında, kamu idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle de sağlamaya yetkili olduğu; kamu idaresi sağlık hizmeti sunucularının, sözleşmede belirtilen götürü bedel karşılığında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sözleşme

kapsamında verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlü oldukları ve sözleşmede belirtilen götürü bedel dışında Kurum'dan veya genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Kanun'da belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel talep edemeyecekleri; götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle temin edilen hizmetler için Kurum'a ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmeyeceği ve fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirleneceği" hükme bağlanmıştır.

Maddenin son fıkrasında ise "sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği" belirtilmiştir.

Bu hükme dayanılarak çıkarılan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği'nin 50. maddesinde ise "Kurum'un, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerini sağlık hizmeti sunucuları ile sözleşme yapmak suretiyle sağlayacağı, yapılacak sözleşmelerin metninin de Kurumca belirlenecek hususları kapsayacak şekilde hazırlanacağı" belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre Kurumumuzca imzalanan sözleşme ve protokoller şu şekilde sıralanabilir[8]:

1) Sosyal Güvenlik Kurumu/Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Protokolü: Kurumumuz ile Sağlık Bakanlığı arasında 15.06.2007-31.12.2007 tarihleri arasında geçerli olmak üzere imzalanan protokolün 9.3. numaralı maddesine göre "her takvim yılının 15 Aralık günü mesai bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde protokolün aynı şartlarla bir yıl daha uzatılması" kabul edildiğinden, 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin 1.2. numaralı maddesinde

[8] İlgili kurumlarla / kuruluşlarla imzalanan protokollerin satın alınacak hizmet içeriğine göre yenilenmesi de mümkün bulunmadığından, denetimler esnasında cari olan protokollerin temin edilmesi unutulmamalıdır.

sayılan kişilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alması işlemleri halen bu protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

2) Sağlık Yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanan Kişilerin Askeri Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından Faydalanmalarına Dair Protokol: Kurumumuz ile TSK Sağlık Komutanlığı arasında 15.06.2007-31.12.2007 tarihleri arasında geçerli olmak üzere imzalanan protokolün 12.2. ve 12.3. numaralı maddelerine göre "her takvim yılının son gününden en az 15 gün önce taraflardan biri değişiklik veya feshi ihbar etmediği takdirde protokolün aynı şartlarla bir yıl daha uzatılması" kabul edildiğinden, 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin 1.2. numaralı maddesinde sayılan kişilerin TSK Sağlık Komutanlığı'na bağlı sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alması işlemleri halen bu protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

3) Sosyal Güvenlik Kurumu/Üniversiteler Sağlık Hizmetleri Protokolü: Kurumumuz ile üniversiteler arasında 31.12.2007'ye kadar geçerli olmak üzere imzalanan protokolün 9.2. numaralı maddesine göre "her takvim yılının 15 Aralık günü mesai bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde protokolün aynı şartlarla bir yıl daha uzatılması" kabul edildiğinden, 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin 1.2. numaralı maddesinde sayılan kişilerin üniversitelere bağlı sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alması işlemleri bu protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

4) Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/ Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi: Kurumumuz ile özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında 31.12.2007'ye kadar geçerli olmak üzere imzalanan protokolün 9.2. numaralı maddesine göre "her takvim yılının 15 Aralık günü mesai bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde protokolün aynı şartlarla bir yıl daha uzatılması" kabul edildiğinden, 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin 1.2. numaralı maddesinde sayılan kişilerin özel sağlık kurum ve

kuruluşlarından sağlık hizmeti alması işlemleri bu sözleşme çerçevesinde yürütülmektedir.

6.2. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Faturalanması Ve Ödenmek Üzere Kurumumuza Gönderilmesi:

Kurumumuzla protokol imzalamış olan ve yukarıda belirtilen resmi makamlara bağlı olan tüm sağlık tesisleri ile sözleşme imzalamış olan tüm özel sağlık hizmeti sunucuları arasındaki sözleşme ve protokol metinlerinde "ilgili sağlık kurumu ya da kuruluşunun sağlık hizmeti sunumu konusunda; SUT, ödeme genelgeleri (2007/46, 2007/46 Ek 1 ve Ek 2 sayılı Genelgeler gibi) ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslara uymayı kabul ve taahhüt ettikleri" belirtilmiştir. Dolayısı ile hizmet sunumu, faturalama ve Kurumumuza ibraz aşamaları ile ilgili bilgiler yukarıda sayılan mevzuatta detaylı olarak açıklandığından ayrıca bir izahata gerek görülmemiş, ancak işbu rehberin ikinci bölümünde başvurulabilecek temel mevzuat kaynakları liste halinde sıralanmıştır.

6.3. Gönderilen Faturaların Örnekleme Yolu İle Kontrolü:

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası Ek Madde 1 ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği'nin 52. maddesine göre; sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kurumumuza gönderilen faturalar, genel sonuçlar verecek şekilde %5 ilâ %10 oranında örnekleme metodu ile incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda bulunan hata oranı sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödenecek tutar tespit edilir ve buna göre ödeme yapılır. Kurum ihtiyaç duyduğu hâllerde faturaların tamamını incelemeye yetkilidir.

Örnekleme yapılarak fatura incelemesi yöntemini kabul etmeyen sağlık hizmeti sunucuları, bu tercihlerini hizmet vermeye başlamadan önce Kurumumuza yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunulmaması hâlinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılır.

Kurum, örnekleme yöntemi ile yapılacak inceleme ve kontrol için Kurum dışından tabip ve eczacı görevlendirebilir. İhtiyaç hâlinde inceleme 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu'na tabi meslek mensupları ile bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.

6.4. Satın Alınan Sağlık Hizmetlerinin Bedellerinin Ödenmesi:

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Ek Madde 1, 5510 sayılı Kanun'un 97. maddesi ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği'nin 52. maddesine göre; sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca Kurum'a teslim edilen fatura ve eki belgelerin, fatura teslim tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde incelenerek ödenmesi esastır. Ancak sağlık hizmeti sunucularının 45 (kırkbeş) gün içinde incelenmesi tamamlanamayan faturaları için, tahakkuk etmiş alacaklarının % 75 ilâ % 90'ı oranındaki tutar, en geç kırkbeşinci gün alacaklarından mahsuben avans olarak ödenir. Fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de fatura ve eki belgelerin incelemesi tamamlanarak geri kalan tutar ödenir. Kurum ödenecek avans oranlarını sağlık hizmeti sunucuları arasında % 75 ilâ % 90 arasında olmak üzere farklı şekilde belirlemeye yetkilidir.

Kurum tarafından, fatura teslim tarihinden itibaren 90 günlük süre içinde fatura ve eki belgelerin incelemesinin tamamlanamaması hâlinde sağlık hizmeti sunucusuna düzenlenen fatura tutarı üzerinden ödeme yapılır. Ancak inceleme işlemlerine devam edilir. İnceleme sonucu fazla ödeme yapıldığının tespiti hâlinde; yapılan fazla ödeme sağlık hizmeti sunucusunun varsa Kurum'dan alacağından mahsup edilir. Alacağının bu miktarı karşılamaması veya alacağının bulunmaması durumunda tahsilât genel hükümlere göre yapılır.

Sağlık hizmet sunucusuna Kurum'da ödeme süresi henüz gelmemiş fatura bedelinden daha yüksek tutarda avans ödemesi yapılmaz. Ödenen avans, tahakkuk miktarından az ise fark sonraki ödeme döneminde ödenir. Bu dönem iki ödeme dönemini geçemez.

5510 sayılı Kanun'un 66. maddesi gereği sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelleri için, yurt dışında bulunan sağlık hizmet sunucusunun talebi hâlinde, sağlık hizmetinin sunumundan önce de avans ödenebilir.

Örnekleme yoluyla faturası incelenecek gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmeleri belirlemeye, örnekleme oranını bu kişi ve işletmeler için birinci fıkrada yer alan oranlar arasında kalmak kaydıyla farklı oranlarda uygulamaya, fatura inceleme ve kontrolüne ilişkin diğer usûl ve esasları, Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın görüşlerini alarak düzenlemeye Kurumumuz yetkilidir.

Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden, verdikleri hizmete ilişkin fatura ve benzeri belgeleri 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 242. maddesine uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı belgelerle birlikte elektronik ortamda göndermelerini isteyebilir. Bu takdirde ilgililere yapılacak ödemeler bu belgeler üzerinde yapılacak incelemelere göre sonuçlandırılır. Elektronik ortamda belge düzenlenmesine, bu belgelerin saklanmak veya incelenmek üzere Kurum'a veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelere iletilmesine, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı'nın görüşlerini alarak belirlemeye Kurum yetkilidir. Bu maddeye uygun olarak yapılan inceleme ve ödeme 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak yapılmış sayılır.

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği'nin 53, 54 ve 58. maddelerine göre; genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hâller hariç olmak üzere aldığı sağlık hizmeti giderleri ödenmez.

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere acil hâllerde sundukları sağlık

hizmetlerini, 5510 sayılı Kanun'un 72. maddesi gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen tutar esas alınarak kişilere fatura eder. Kurumca yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar, fatura karşılığı kişilere ödenir.

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları acil hallerde, 5510 sayılı Kanun'un 72. maddesi gereği belirlenen tutarlar dışında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurum'dan herhangi bir fark talep edemez.

Ayakta veya yatarak sağlık hizmeti sunan sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusundan satın alınan sağlık hizmeti giderinin Kurumca ödenebilmesi için; sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusunun, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat, izin, uygunluk ya da onay belgesini almış olması şarttır.

18 yaşını doldurmamış çocukların, kısıtlıların veya kendisine kayyum tayin edilen kişilerin sağlık hizmeti sunucusunda yapmış olduğu giderlerin Kurumca ödenecek tutarı, bunların velisine, vasisine, kayyumlarına veya ilgili mevzuatla yetkilendirilen kuruluşların yetkili personeline ödenir.

Kurumca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile sağlık hizmeti sunucularına, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler, Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre geri alınır.

BÖLÜM 2
HASTANE DENETİMLERİNDE YARARLANILACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Hastane denetiminde başvurulabilecek bazı mevzuat hükümleri aşağıda listelenmiş olup, yürütülecek tüm hastane denetimleri esnasında, incelenen dönemde cari olan mevzuatın temin edilmesi unutulmamalıdır.

2.1. Kanunlar

Sıra No.	Kanun No.	RG Tarihi	RG No	Adı
1	5565	29.12.2006	26391 (Mük.)	2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
2	5724	28.12.2007	26740 (Mük.)	2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
3	2022	10.07.1976	15642	65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
4	5258	09.12.2004	25665	Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
5	5335	27.04.2005	25798	Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6	4854	06.05.2003	25100	Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun
7	6197	24.12.1953	8591	Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
8	5615	04.04.2007	26483	Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
9	6283	02.03.1954	8647	Hemşirelik Kanunu
10	2219	06.06.1933	2419	Hususi Hastaneler Kanunu
11	1262	26.05.1928	898	İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
12	5326	31.03.2005	25772 (Mük.)	Kabahatler Kanunu
13	5624	02.05.2007	26510	Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
14	2918	18.10.1983	18195	Karayolları Trafik Kanunu
15	3065	02.11.1984	18563	Katma Değer Vergisi Kanunu
16	5525	04.07.2006	26218	Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
17	4483	04.12.1999	23896	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
18	4341	22.02.1998	23266	Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun
19	2330	06.11.1980	17152	Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
20	5490	29.04.2006	26153	Nüfus Hizmetleri Kanunu

21	5193	26.06.2004	25504	Optisyenlik Hakkında Kanun
22	2238	03.06.1979	16655	Organ Ve Doku Alınması, Saklanması Ve Nakli Hakkında Kanun
23	3816	03.07.1992	21273	Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
24	3359	15.05.1987	19461	Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
25	224	12.01.1961	10705	Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
26	2368	31.12.1980	17207 (Mük.)	Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun
27	1219	14.04.1928	863	Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
28	7201	19.02.1959	10139	Tebligat Kanunu
29	5233	27.07.2004	25535	Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
30	5237	12.10.2004	25611	Türk Ceza Kanunu
31	3224	25.06.1985	18792	Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
32	6643	02 .02.1956	9223	Türk Eczacılar Birliği Kanunu
33	6023	31.01.1953	8323	Türk Tabipleri Birliği Kanunu
34	6762	09.07.1956	9353	Türk Ticaret Kanunu
35	1593	06.05.1930	1489	Umumi Hıfzısıhha Kanunu
36	6968	24.05.1957	9615	Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

2.2. Tüzükler

Sıra No.	İlgili Kanun No.	RG Tarihi	RG No	Adı
1	3153	12.10.1957	9730	Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Tüzük
2	2219	10.01.1983	17924	Özel Hastaneler Tüzüğü
3	2827	18.12.1983	18255	Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük
4	6023	19.02.1960	10436	Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
5	1219	19.06.2002	24790	Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
6	6643	27.07.1968	12961	Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü

2.3. Yönetmelikler

Sıra No.	İlgili Kanun No.	RG Tarihi	RG No	Adı
1	3359/1219/ 181 KHK/2918	11.05.2000	24046	Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
2	3359/1219/181 KHK	14.10.1999	23846	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
3	5258	06.07.2005	25867	Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik
4	3359/1219/181 KHK	17.09.2002	24879	Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
5	3359/1219/ 181 KHK/2918	07.12.2006	26369	Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
6	3359/1219/ 181 KHK	15.02.2008	26788	Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
7	1262/3359/ 181 KHK	12.08.2005	25904	Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği
8	1262/3359/ 181 KHK	09.10.2003	25254	Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
9	1262/3359/ 181 KHK	23.10.2003	25268	Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği
10	1262/3359/2857/ 181 KHK	19.01.2005	25705	Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
11	1262/3359/ 181 KHK	22.03.2005	25763	Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
12	1219/1262/3359/ 2313/181 KHK/1961 ve 1971 BM Sözleşmeleri/AB 2001/83/EC Direktifi	17.02.2005	25730	Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik
13	1262	23.10.2003	25268	Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
14	657	11.08.1973	14622	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve

				Cenaze Giderleri Yönetmeliği
15	3359/181 KHK	08.05.2005	25809	Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
16	6197/181 KHK	13.10.1992	21374	Eczacılar Ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
17	5510	27.09.2008	27010	Fazla veya Yersiz Odemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18	5510	28.08.2008	26981	Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
19	3359/181 KHK	01.08.1998	23420	Hasta Hakları Yönetmeliği
20	1219/3359/181 KHK	01.08.2001	24480	Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
21	5176	13.04.2005	25785	Kamu Görevlileri İle Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
22	4375	11.08.1999	23783	Kamu Personeli İle Bunların Emeklilerinin Yurtdışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
23	2857	25.11.1983	18232	Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği (Eski)
24	5624, 181 KHK	04.12.2008	27074	Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği (Yeni)
25	181 KHK	14.12.2000	24260	Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği
26	181 KHK/3359/AB'nin 2001/20/EC ve 2005/28/EC sayılı direktifleri	23.12.2008	27089	Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
27	657	06.02.1981	17243	Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
28	181 KHK	01.06.2000	24066	Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
29	3816	13.08.1992	21314	Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik
30	3359/181 KHK	27.03.2002	24708	Özel Hastaneler Yönetmeliği
31	1262/3359/ 181 KHK	23.05.2005	25823	Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik
32	4703/1593/5324/ 181 KHK	25.06.2007	26563	Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

33	5510	11.10.2008	27021	Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
34	657/4792	04.11.1999	23866	SSK Eğitim Hastaneleri İle Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Üniversite Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
35	1219	22.05.1974	14893	Tababet Uzmanlık Yönetmeliği
36	3359/181 KHK	30.07.2000	24125	Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik
37	4703/3359/181 KHK	09.01.2007	26398	Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
38	6023	28.04.2004	25446	Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
39	A219/3359 sy Konular	15.02.2008	26788	Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
40	4703/3359/181 KHK	09.01.2007	26398	Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
41	4703/3359/181 KHK	09.01.2007	26398	Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
42	10.9.1982, No: 8/5319 BKK	13.01.1983	17927 (Mük.)	Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

2.4. Tebliğler

Sıra No.	RG Tarihi	RG No.	Adı
1	30.05.2006	26183	2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi Ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1)
2	15.07.2006	26229	2007-2009 Dönemi Bütçe Çağrısı
3	28.09.2008	27011	5510 sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ
4	28.09.2008	27011	5510 sayılı Kanun'un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ
5	28.09.2008	27011	5510 sayılı Kanun'un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
6	22.09.2007	26651	Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
7	03.03.2004	25391	Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ
8	06.11.2004	25635	Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ
9	07.12.2006	26369	Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "Medula" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)
10	09.10.2008	27019	Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
11	28.09.2008	27011	Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği
12	10.05.2005	25811	Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
13	02.03.2004	25390	Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ
14	25.05.2007	26532 (Mük.)	SGK 2007 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği
15	29.09.2008	27012 (Mük.)	SGK 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği

16	22.10.2008	27032	SGK 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
17	29.04.2006	26153	Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)
18	31.05.2006	26184	Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)
19	01.07.2006	26215	Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)
21	23.10.2008	27033	Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6)
22	31.12.2008	27097 (7. Mük.)	Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (No.7)
23	31.12.2008	27097 (7. Mük.)	SGK 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No.8)
24	31.12.2008	27097 (7. Mük.)	Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
25	17.01.2009	27113	SGK 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
26	29.01.2009	27125	SGK 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
27	31.01.2009	27127	SGK 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28	28.02.2009	27155	Diyaliz Sertifikalarının Resertifikasyonu Hk. Tebliğ
29	03.04.2009	27189	SGK 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2.5. Bakanlar Kurulu Kararları

Sıra No.	Karar Tarih/No.	RG Tarihi	RG No.	Karar Adı
1	2008/13152	06.02.2008	26779	Bağ-kur Emeklilerinden Sağlık Sigortası Primi Kesilmesine İlişkin Karar
2	2007/11830	21.03.2007	26469	Bağ-kur Emeklilerinden Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Kararı
3	2004/6781	14.02. 2004	25373	Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar
4	2007/12325	30.06.2007	26568	Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması
5	2007/12377	20.07.2007	26588	09.07.2007 tarihli ve 2007/12377 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

6	2008/13284	08.03.2008	26810	Kamu Hizmetlerinden Ücretsiz Veya İndirimli Yararlanma İle İlgili Bazı Kararlar
7	2008/13728	04.06.2008	26896	Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
8	10.09.1982/ 8-5319	13.01.1983	17927 (Mük.)	Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

2.6. Genelge ve Genel Yazılar

Sıra No.	Tarihi	Sayısı	Konusu
1	11.01.2007	2007/3	Tıbbi Sarf Malzemeleri
2	24.01.2007	2007/6	Poliklinik Muayene Ücretleri
3	---	2007/13	Manyetik Rezonans (Kapalı Sistem) Konu
4	15.03.2007	2007/21	Hekim Yetkilendirme Sistemi
5	---	2007/26	Yurtdışından İlaç Temini Protokolü
6	---	2007/32	Üniversite Hastanelerinin Alacaklarının Terkini
7	21.05.2007	2007/38	Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşların Alacaklarının Terkini
8	---	2007/41	Manyetik Rezonans (Kapalı Sistem)
9	13.06.2007	2007/46	Fatura Bedellerinin Ödenmesi
10	25.06.2007	2007/54	SUT'a Ek Genelge
11	04.07.2007	2007/46 Ek 1	2007/46 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
12	04.07.2007	2007/55	SUT'un Bazı Maddelerinde Değişiklikler
13	12.07.2007	2007/58	KPS ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
14	20.07.2007	2007/64	Sağlık Uygulama Tebliği
15	10.08.2007	2007/68	SUT Ek 2 ve Ek 2-E Bendine İlişkin Değişiklikler
16	10.08.2007	2007/69	Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Yetki Devri
17	21.09.2007	2007/71	SUT'un Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
18	26.09.2007	2007/73	Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri
19	03.10.2007	2007/76	Akülü Tekerlekli Sandalye
20	10.10.2007 16.03.2009	2007/78 Kurumun internet sayfasında	SUT'un Bazı Maddelerinde Değişiklikler Yapılması Hakkında
21	26.10.2007	2007/82	Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Yaşanan Sorunlar
22	20.11.2007	2007/89	Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı
23	26.12.2007	2007/96	Sağlık Karnesi Uygulaması
24	31.12.2007	2007/97	Sağlık Uygulama Tebliği

25	14.01.2008	2008/3	Sağlık Karnesi Ücretleri
26	04.02.2008	2008/10	Poliklinik Muayene Ücretleri
27	04.02.2008	2008/11	Katılım Payı Alınacak Protez, Ortez ve Diğer
28	19.03.2008	2008/15	SUT Eki Ek 2/D'de Yapılan Düzenlemelerle İlgili Genelge
29	04.04.2008	2008/17	Devredilen Bağ-Kur ve T. C. Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Uygulaması
30	04.04.2008	2008/18	SUT ve Genelge Değişikliği
31	02.04.2008	2008/19	2531 Sayılı Yasa'daki (Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler) Değişiklik
32	03.04.2008	2008/20	Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat
33	---	2008/23	TSK Protokolü
34	11.04.2008	2008/25	SUT Eki Ek 2/D'de Yapılan Düzenlemelerle İlgili Genelge
35	17.04.2008	2008/28	Otogreftler, Allogreftler, DBM İnsan Dokusu Ürünleri Ödemeleri
36	24.04.2008	2008/33	Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı
37	06.05.2008	2008/35	Hava ve Deniz Ambulans Bedelleri
38	15.05.2008	2008/41	SUT Değişikliği
39	27.05.2008	2008/46	Sağlık Karnesi Uygulaması
40	20.06.2008	2008/55	Sosyal Güvenlik Merkezleri
41	23.06.2008	2008/56	Faktör VIIa
42	27.06.2008	2008/57	Sağlık Karnesi Ücretleri
43	30.06.2008	2008/59	5510 Sayılı Kanun
44	30.06.2008	2008/60	Üniversite Protokolü
45	30.06.2008	2008/61	Sözleşmeler
46	07.07.2008	2008/64	Genel Sağlık Sigortasının 01.09.2008 İtibarı İle Yürürlüğe Giren Hükümleri
47	18.07.2008	2008/68	Danıştay Kararı
48	29.07.2008	2008/70	Sosyal Güvenlik Merkezleri
49	01.08.2008	2007/46 Ek 2	Fatura Bedellerinin Ödenmesi
50	13.08.2008	2008/75	SUT ve eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili Genelge
51	28.08.2008	Yönerge	Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
52	01.09.2008	Olur	Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Ait Veriler
53	04.09.2008	2008/80	Danıştay Kararı
54	14.10.2008	2008/86	Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
55	14.10.2008	2008/87	Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları
56	31.10.2008	2008/90	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
57	07.11.2008	2008/91	Sosyal Güvenlik Merkezleri
58	17.11.2008	2008/98	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci

			Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
59	24.11.2008	2008/100	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan düzenlemeler
60	26.11.2008	2008/101	Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri
61	04.12.2008	2008/105	SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler
62	15.12.2008	2008/107	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
63	22.12.2008	2008/109	Servikal disk protezleri, Pedikül vida yerleştirici , Perkutan interbody füzyon ve vida fiksasyonu ödeme kriterleri
64	22.12.2008	2008/110	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
64	29.12.2008	2008/112	Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
65	05.01.2008	2009/1	Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
66	05.01.2009	2009/4	Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
67	12.01.2009	2009/7	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
68	15.01.2009	2009/9	3713 sayılı Kanun
69	15.01.2009	2009/10	Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı
70	15.01.2009	1463430	Sağlık Hizmet Sunucularına Yapılacak Ödemeler ve Verilen Avansların Kapatılması
71	15.01.2009	1463821	Yeni Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Muhasebe İşlemleri
72	19.01.2009	2009/14	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
73	27.01.2001	2009/15	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
74	28.01.2009	2009/16	SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler
75	02.02.2009	2009/19	SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7.maddesine göre yapılan düzenlemeler
76	09.02.2009	2009/24	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
77	17.02.2009	2009/27	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
78	24.02.2009	2009/32	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
79	03.03.2009	2009/34	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

80	06.03.2009	2009/39	Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri
81	06.03.2009	2009/40	2008 SUT Uygulamaları
82	06.03.2009	2009/41	Yurtdışı Tedavi İşlemleri
83	10.03.2009	2009/43	SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7.maddesine göre yapılan düzenlemeler
84	12.03.2009	2009/44	Fatura Bedellerinin Ödenmesi
85	16.03.2009	2009/45	SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7.maddesine göre yapılan düzenlemeler
86	25.03.2009	2009/51	SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7.maddesine göre yapılan düzenlemeler
87	02.04.2009	2009/54	Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7,5-1(e) ve 5-1(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

(*) Mevzuat listesi 06.04.2009 tarihi itibarı ile listelenmiş olup, bu tarihten sonra çıkarılan mevzuatın ilgili müfettişlerce izlenip derlenmesi gerekmektedir.

2.7 Duyurular ve Diğer Mevzuatlar

Kurumun her türlü duyuruları www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Hekimlik mesleğine ilişkin etik kurallar ve kurallara uymamanın müeyyidesi Türk Tabipler Birliğinin web sayfasında (http://www.ttb.org.tr) 01.02.1999 tarihinde yayınlanan "Hekimlik Mesleği Etik Kuralları" ile belirlenmiştir.

BÖLÜM 3

HASTANE DENETİMİ SÜRECİ

3.1. Amaç, Genel İlkeler ve Yöntem

3.1.1. Amaç:

Kurumumuz Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak hastane denetimlerinde genel amaç;

- Kurumumuzca finanse edilen sağlık hizmetlerinin etkililik (hedeflenen sonuçlara ulaşma derecesi) ve verimliliğini (ulaşılan sonuçların kullanılan girdilere oranı) yerinde görerek değerlendirmek,

- Hedeflere ulaşılmasını engelleyen suiistimalleri ya da eksiklikleri ortaya koymak,

- Bunların tekrarlanmasını önlemek için caydırıcı, eğitici ve iyileştirici önlemler alınmasını sağlamaktır.

Bu amaç çerçevesinde;

- Kurumumuzca finanse edilen sağlık hizmetlerinin 5510 sayılı Yasa'da kapsamı belirtilen ve sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip genel sağlık sigortalıları dışındaki kimselere verilip verilmediğini inceleyerek, sınırlı kaynakların gerçek ihtiyaç sahipleri için harcanmasına ve bu yolla Kurum kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmak,

- Sağlık yardımlarının bu konudaki düzenleyici mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme ve protokoller, vb.,) hü-

kümlerine uygun şekilde sunulup sunulmadığını inceleyerek Kurumumuzun bu alandaki etkililiğini ve kontrolünü arttırmak, sunulan hizmetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak,

- Sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetlerinin tıp alanında genel kabul gören esaslara uygunluğunu inceleyerek hastaların kaliteli sağlık hizmeti almalarına katkı sağlamak,

- Kurumumuzun sağlık giderlerini arttıran ya da hastaların sağlığını tehlikeye sokan suiistimalleri tespit ederek sorumluların cezalandırılması ile zararın tespit ve tahsilini sağlamak,

- Sağlık hizmetlerinin sunumu, izlenmesi ve analiz edilmesinde yardımcı rol üstlenen bilgi işlem ve karar destek sistemlerinde yer alan verilerin doğruluğunu ve tasarlanma amacına hizmet edip etmediğini inceleyerek Kurum zararına yol açabilecek ya da hizmetten faydalananları sıkıntıya uğratabilecek program eksikliklerini tespit etmek, yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesine yönelik öneriler getirmek,

- Yapılan tespitler ışığında, benzer suiistimallerin engellenebilmesi için caydırıcı, önleyici, düzeltici ya da eğitici mahiyette olmak üzere, yapılması gereken mevzuat değişiklikleri, oluşturulması gereken insan ya da bilgisayar odaklı kontrol prosedürleri, kurulması gerekli birim ya da servisler, tasarlanması gereken bilgisayar yazılımları vb. hususlarda önerilerde bulunmak,

hususlar Müfettişlerin görev alanına girmektedir.

3.1.2. Genel İlkeler:

Bilindiği üzere, 19.01.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5283 sayılı 'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun'un 19.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren 4. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı'na devredilerek; Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri dışında, devlet tarafından sunulan tüm sağlık hizmetlerinin tek elde toplanması sağlanmıştır. Kanun gereğince, o tarihte sağlık hizmetini bizzat sunan tek sosyal güvenlik kurumu olan Sosyal Sigortalar Kurumu, mülkiyetindeki hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devrederek T. C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ile birlikte sağlık hizmeti satın almaya başlamıştır. Bilahare, 20.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kurulan Kurumumuz da sağlık hizmetlerini resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokol ya da sözleşmeler çerçevesinde satın almak yolu ile karşılamakta ve zaman zaman bu kuruluşlar üzerinde denetim yetkisini kullanmaktadır.

Söz konusu kanunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev alanını belirleyen 17. maddesinin (f) bendinde "sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler" hakkındaki yetkimizin "inceleme ve soruşturma yapmaktan" ibaret olduğu belirtilmektedir. Dolayısı ile, Müfettişlere gelecek tüm hastane denetimi görevlendirmeleri inceleme ya da soruşturma amaçlı olacaktır.

Bu çerçevede Müfettişler tarafından yürütülecek hastane denetimlerinde göz önünde bulundurulacak genel ilkeler şu şekilde özetlenebilir:

a) Tarafsızlık Prensibi: Müfettişler, elde ettikleri her bilgi ve belgeyi hakkaniyeti sağlama amacına yönelik ve objektif olarak incelemeli, Kurumumuza yarar sağlayacak olsa bile delillerle desteklenmemiş ya da makul dayanaktan yoksun gerekçelerle hareket ederek, kişilerin ya da kuruluşların zararını hedef tutan ya da bunu düşündürecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Yaptığı iş sonucunda düzenleyeceği raporun çok farklı kişi ve kurumların dikkatine sunulacağını düşünerek; şahsının, unvanının, mesleğinin, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın ve Kurumumuzun saygınlığına ve güvenilirliğine gölge düşürmemelidir. İnceleme ve soruşturmanın her aşamasında, deliller ne kadar açık görünürse görünsün konuyu her yönden (lehte ve aleyhte) tahlil ve değerlendirmeye tabi tutmalı, hissî davranmaktan kaçınmalıdır.

b) Gizlilik ve Güvenlik Prensibi: Müfettişler hastane denetimi kapsamındaki incelemelerin başlangıç, yürütme ve sonuçlandırma safhalarının her anında gizliliğe uymalı, gereken kimseler dışında denetim mahallini, denetim yapıldığını ve denetim konusunu açıklamamalı, özellikle denetim mahallinde sürekli olarak çalışılması durumunda, kullandığı oda ve incelediği belgelerin güvenliğini sağlamalıdır.

Denetim gerekçesinin mahiyetine göre, denetlenen kişi ya da kuruluşların denetime alındıklarının bilinmesi halinde sonuçta bir suiistimal bulunmasa bile itibar kaybına uğramaları riski var ise, delil toplanması ve ifade alınması safhaları da dâhil olmak üzere gizlilik esasına daha da özenli biçimde riayet edilmeli, verilen talimatlara ve Müfettişlerce takdir edilecek "gizlilik" ve "güvenlik" prensiplerine uygun şekilde hareket edilmelidir.

c) İcranın Dışında Kalma Prensibi: Müfettişler hastane denetimi esnasında, gerek konu ile ilgili olarak muhatap olduğu Kurumumuz personeline gerekse denetlenen hastane personeline bir işin yapılması ya da yapılmaması hususunda emir vermemeli, birim amirlerinin yerini alarak ya da onların talimatlarını geçersiz kılacak şekilde hareket etmemeli, Kurumumuz adına taahhütte bulunulduğunu düşündürecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Ancak, herhangi bir mevzuat hükmüne açıkça aykırı bulunan bir davranış ya da uygulamanın tespiti halinde ilgilileri mev-

zuata uygun şekilde davranmaya davet etmek yahut bağlayıcı olmamak şartı ile bir hususu ilgililerle istişare etmek halleri bu durumun dışındadır.

d) Kanaatin Gizliliği (İhsas-ı Reyden Kaçınma) Prensibi: Müfettişler hastane denetimi esnasında muhatap olduğu kimselere, denetim sonunda vardığı kanaati belli etmemeli, olay ne denli açık görünürse görünsün vardığı kanıyı kimseye açıklamamalıdır. Bilhassa şahıslarla ilgili olarak yapılan inceleme ve soruşturmalarda bu hususa riayet edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır.

Ancak, bir kadın doğum uzmanınca gerçekleştirilen kürtaj işleminin Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine Dair Tüzük hükümlerine ya da hastane tarafından gerçekleştirilen bir faturalama işleminin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı olup olmadığını anlamak için ilgililere soru yöneltilmesi hallerinde olduğu gibi, incelenen olayın mahiyetini anlamaya yönelik olarak ilgililerle yapılan istişareler esnasında zorunlu olarak ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz değerlendirmeler bu durumun dışındadır.

e) Denetimler esnasında, yapılan görevlendirmenin inceleme ve/veya soruşturma amaçlı olduğu daima göz önünde bulundurularak denetim kapsamı buna göre belirlenmeli ve zaman kaybına yol açacak gereksiz incelemelerden kaçınılmalı, gayeye en kısa ve emin yoldan varacak şekilde hareket edilmeli, konu ile ilgisi olmayan kişilerin lüzumsuz yere dinlenmesinden ve ispat vasıtası olamayacak kayıt ve belgelerin araştırılmasından kaçınılmalıdır.

f) Denetim ile ilgili araştırmalara başlanılmadan önce konuya ait mucip ve eki belgeler etraflıca tetkik etmek suretiyle ilgili mevzuat, şahıslar, olaylar ve belgeler hakkında bilgi edinilmeli, denetim gerektiren riskli noktalar belirlenmeli; öte yandan, incelenecek konu hakkında fayda/maliyet analizi yapılarak,

denetim sonucunda elde edilecek bilgilerin, bunun için harcanan zamana ve emeğe değip değmeyeceği irdelenmelidir.

g) Konunun tanımlanmasından sonra denetimin ne şekilde yürütüleceği, hangi bilgi ve belgelerin toplanması gerektiği, gerekli görülürse kimlerin ifadesine başvurulabileceği, hangi bilgilere ve kayıtlara müracaat edilebileceği ve muhtemel durumlara göre ne tarzda hareket edileceği, zaman ve mekân itibariyle sıralanarak planlanmalıdır.

h) Denetimin her aşamasında bütüncül bir yaklaşım sergilenmeli, denetlenen bilgi ve belgelerin denetim alanına, denetim alanının ise denetimin amacına ve görevlendirme emrinin kapsamına uygun olması her aşamada sağlanarak aradaki bağlantı kaybedilmemelidir. Bu ilkenin, "müfettişin kendisi için öz denetim yapması" şeklinde tarif edilmesi de mümkündür.

ı) Hastane denetimleri esnasında bilhassa denetimin mahallinde yürütüldüğü durumlarda hastane yetkililerine ve diğer ilgililere karşı nazik hareket edilmeli, asabî davranışlardan kaçınılmalı, ketum olunmalı, aleyhlerindeki deliller kesin olarak tespit edilip suçlulukları sabit görülse bile ilgililere suçlu oldukları intibaı verilmemelidir.

i) Yürütülecek incelemeler esnasında mevzuatın sık sık değişebildiği göz önüne alınarak, inceleme konusu edilen her işlem ya da eylemin yapıldığı tarihteki cari mevzuata göre değerlendirilmesi unutulmamalıdır.

j) Denetimlerin her aşamasında ve her türden eksiklik ve aksaklığa rastlamak mümkün olduğundan, böyle bir durumda tespit edilen aksaklığın Kurum aleyhine bir kasıttan mı, ilgililerin kusurundan mı yoksa ihmalinden mi kaynaklandığı, kasıt, kusur ve ihmalin Türk Ceza Kanunu açısından bir yaptırımı gerektirip gerektirmediği, gerektiriyorsa zamanaşımı, ehliyet vs. hususlardan dolayı cezai takibatın sekteye uğrayıp uğramayacağı, cezai bir yönü olmamakla birlikte Kurum aleyhine

ya da sözleşme/protokole aykırı bir yönü olup olmadığı iyice anlaşılmalıdır.

k) İnceleme ve soruşturma konuları, adli mercilerce de ele alınmış olsa bile, başka bir araştırmaya ihtiyaç göstermeyecek şekilde tamamlanmalıdır.

l) Hastane denetimlerinin soruşturma şeklinde gerçekleştirildiği durumlarda, suç teşkil ettiği düşünülen eylemlerin incelemesine geçilmeden önce suçun mahiyetine göre gerekli zamanaşımı süreleri dikkate alınmalı, ilgisine göre idari ve mali yönden işlem tesis edilmesi gerektirmeyen işlerde disiplin cezası ya da TCK yönünden zamanaşımına girmiş eylemlerin incelemesi ile vakit kaybedilmemelidir.

m) İhbar ve şikâyet konusu edilen eylemlerin, mahiyetlerine ve işlendiği tarihlere göre affa tabi olup olmadığı araştırılmalı, bu hususta affın suçun bütün sonuçlarını da kapsayacak mahiyette olup olmadığı ilgili kanunundan tetkik edilmeli ve düzenlenecek raporlarda bu husus nazara alınmalıdır.

n) Denetim esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki hekim/uzman hekimlerden, üniversite hastanelerinde görev yapan uzmanlardan ya da İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilecek uzman hekimlerden istifade edilmelidir. Ancak denetimin gidişatının etkilenmesinin söz konusu olmadığı durumlarda denetlenen hastanelerin müfettiş tarafından güvenilir kabul edilen uzmanlarından yararlanılması da mümkündür. Bu incelemeler sonucunda bilirkişi raporu düzenlenmesi halinde düzenlenen bilirkişi raporu kanıtlayıcı belge olarak raporlara eklenmeli, uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderlerinin ödenmesi için müfettiş tarafından bir yazı düzenlenerek Kurum'a intikal ettirilmeli, bu esnada "bilirkişilik" müessesesi konusundaki Ceza Muhakemesi Kanunu düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.

o) Denetim esnasında bir suiistimal tespit edilmekle birlikte, bilhassa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu ya da sözleşme feshi gibi ciddi yaptırımların doğru muhataplara yöneltilmesini teminen, suiistimalin kim ya da kimler tarafından işlendiği ortaya çıkarılmalı, özellikle hastane yönetiminin bu işte bir rolü olup olmadığı netleştirilmelidir.

ö) Denetimler sonucunda varılacak vicdani kanaatlerin tereddüde mahal vermeyecek bir şekilde delillere, ifadelere, onaylanmış bilgi ve kayıtlara ya da makul gerekçelere dayandırılmasına özen gösterilmeli, zan ve tahminler üzerine herhangi bir yorumda bulunulmamalıdır.

p) Tespit edilen her türlü hususun rapora konu edilmeye değer olup olmadığı değerlendirilmeli, bu değerlendirme sonucunda rapora alınmasına karar verilen tüm hususlar konu hakkında müfettiş kadar bilgi sahibi olmayan herhangi bir kişinin de anlayabileceği şekilde izah edilmelidir. Bu esnada yapılan tespitin mahiyeti açıklanmalı, ilgililer açısından olumlu ya da olumsuz açıdan delil olabilecek niteliği bulunan leh ve aleyhteki belge, kayıt, bilgi veya şahadet gibi her türlü karine, emare, delil ve vakıalar birbirlerini tamamlayacak şekilde izah edilmeli, fiil ve olaylar oluş sırasına göre tahlil edilip değerlendirilmelidir.

r) Gerek denetim gerekse raporlama esnasında; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yayınlanan Teftiş ve Denetim Rehberi, talimat ve genelgeler ile bu rehberde belirtilen diğer hususlara riayet edilmelidir.

3.1.3. Yöntem

Yukarıda izah edilen genel amaçlar doğrultusunda yürütülecek olan hastane denetimlerinin nasıl bir yöntem ile yürütüleceği; mucibin kapsamı, incelenen fatura sayısı, denetime konu tıbbi branşın mahiyetinden kaynaklanan farklılıklar gibi pek çok faktöre göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle tek bir ideal yöntem belirlenmesi söz konusu olmayıp kullanılacak denetim yönteminin görevli müfettiş ya da müfettişlerce ve içinde bulunulan şartlara göre belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bu rehberde önerilen yöntemler tavsiye niteliğindedir. Ancak, tababet meslek ve sanatının genel kabul görmüş kurallarına uygunluğun hukuka uygunluk olduğu unutulmamalıdır.

3.1.3.1. Fatura Odaklı Denetim: Genel olarak hastane denetimlerinde başvurulabilecek ilk yöntem; denetlenen hastane tarafından düzenlenerek Kurumumuzdan bedelleri tahsil edilmiş faturalar üzerinden hareket etmektir. Görev emrinde belli bir doktor, hasta, tıbbi işlem, tıbbi branş, malzeme ismi vs. belirtilmeyip genel olarak hastanenin Kurumumuz adına sunduğu sağlık hizmetlerinin faturalanmasında herhangi bir suiistimal olup olmadığının denetlenmesi istendiğinde bu yöntem kullanılabilir.

Yöntemin hareket noktası, işlemi gerçekleştiren hastane tarafından düzenlenerek MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortamda Kurumumuzun bilgi işlem sistemine gönderilen ya da kağıda dökülerek sağlık sosyal güvenlik merkezlerindeki fatura inceleme komisyonlarına ibraz edilen faturalar üzerinde genel nitelikli bir inceleme yaparak en yüksek tutarlı faturaları ya da her branş içinde ortalama tutardan yüksek olan faturaları incelemeye almaktır. Bu yöntemde MEDULA'dan (Kurum bilgi işlem sisteminden) ve gerekirse denetlenen hastanede kurulu bilgi işlem sisteminden istifade etmek zorunludur.

Yöntemin en büyük zorluğu MEDULA içerisinde kayıtlı fatura tutarlarını belli bir aralıkta süzmeyi sağlayacak bir menünün bulunmamasıdır. Bu nedenle MEDULA sistemine girilip herhangi

bir fatura dönemini seçmek, seçilen dönemdeki ayaktan ve yatan hasta faturalarını her branş için ayrı ayrı olmak üzere etüd etmek, ardından en yüksek tutarda fatura düzenlenen branşlar içinde en yüksek bedelli faturaları tek tek tespit ederek detaylarına inmek gerekmektedir. Bu yöntem basit olmakla birlikte zaman alıcı olup, zaman kaybını telafi etmek ve denetimin etkililiğini arttırmak için Kurumumuzun ya da hastanenin bilgi işlem sisteminden ihtiyaca özel bilgilerin ayrı bir programla süzülmesi talep edilebilir. Bu talep yapılırken, talep edilen listede yer alması istenilen bilgilerin neler olduğu ayrıntılı olarak belirtilmeli, mümkünse istenilen bilgilerin yerleştirileceği listenin bir örneği talep yazısı ekinde ilgili birime iletilmelidir. Listenin tasarımı yapılırken gönderilen bilgilerde hata olup olmadığının kontrolü için istenilen parametrelerin de listede bulunmasına ve listenin incelenen her faturanın ayırıcı özelliklerini ihtiva etmesine dikkat edilmelidir.

Örnek: "31.12.2007 tarihinden önce" "A Hastanesi" tarafından Kurumumuza gönderilerek "kabulü yapılmış" ve "ödemesi tamamlanmış", "tutarı 2000 YTL'nin üzerinde" ve "kesinti tutarı "0" olan" "kardiyoloji" branş faturalarının listesi.

Sıra No.	Hastane Adı	İlgili Branş	Fatura Kabul Tarihi	Durumu	Fatura Tutarı	Kesinti Tutarı	Hasta TCK No.	Takip Tarihi	Takip No.	Hasta Adı ve Soyadı
1	A	Kardiyoloji	06.12.2007	Ödemesi Tamamlandı	2572,98.-	0.-	36679171482	22.09.2007	2NON79	Fatma TOKUR

Örnek: "01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasında" "B Hastanesi" tarafından Kurumumuza gönderilerek "kabulü yapılmış" ve "ödemesi tamamlanmış", "tutarı 1000-2000 YTL arasında" ve "kesinti tutarı "0" olan" "yatan hasta" faturalarının listesi.

Sıra No.	Hastane Adı	Hastanın Durumu	Fatura Kabul Tarihi	Durumu	Fatura Tutarı	Kesinti Tutarı	Hasta TCK No.	Takip Tarihi	Takip No.	Hasta Adı ve Soyadı
1	B	Yatan	14.02.2008	Ödemesi Tamamlandı	1340,19	0.-	49255243060	26.10.2007	2EQ5DN	Atilla TÜMDAĞ

3.1.3.2. Tıbbi İşlem Odaklı Denetim: Bu yöntemde herhangi bir tıbbi işlem seçilerek bu işleme alınan hastalar tespit edilir ve işlem detaylarına inilerek; faturalamanın usulüne uygun olup olmadığı,

fiyatlarda şişirme yapılıp yapılmadığı, incelenen işlemin yapılması için gereken şartların uygun olup olmadığı gibi yönlerden inceleme yapılır. Bilhassa inceleme konusunun belli bir tıbbi işlem üzerine olduğu durumlarda kullanılabilecek bu yöntemin bazı branşlarda yoğun şekilde fatura düzenleyen hastanelerin denetiminde de kullanılması mümkündür. Ancak bu tür hastaneler denetlenirken incelenecek işleme karar verilemiyorsa ilk olarak Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan fiyat listeleri (özellikle Ek-8 ve Ek-9) incelenerek tutarı en yüksek işlemlerin belirlenmesi ve bu işlemlere alınan hastaların dosyalarına ağırlık verilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır.

Bu yöntemde de MEDULA'dan ve gerekirse denetlenen hastanede kurulu bilgi işlem sisteminden istifade etmek zorunlu olup fatura odaklı denetim yönteminde yaşanan zorluklarla karşılaşılabilir.

Örnek: "01.12.2007-31.01.2008 tarihleri arasında" "B Hastanesinde" "700.810 kodlu" "Selektif Koroner Anjiyografi işlemine alınan", "ödemesi tamamlanmış" ve "kesinti miktarı "0" olan" hastaların listesi.

Sıra No.	Hastane Adı	Hasta TCK No.	Takip Tarihi	Takip No.	İşlem Tarihi	Hasta Adı Soyadı	İşlem Kodu	Durumu	İşlem Tutarı	Kesinti Tutarı
1	B	13549233594	04.12.2007	2Z7QZS	05.12.2007	E. Hasan AYDINBEK	700.810	Dönem Sonlandırıldı	114,13	0.-

3.1.3.3. Sayı Odaklı Denetim: Bu yöntem daha çok Sağlık Uygulama Tebliği'nde nicel yönden sınırlanmış olan işlemlerde suiistimal olup olmadığını ya da belli işlemlere makul bir sayıdan fazla alınan hastaları tespit edip incelemeye uygundur. Örneğin; denetlenen hastanenin SUT Ek-8'de 530.120 kodu ile yer alan "4 saatlik Fototerapi Seansı" işleminin günde 6 adetten fazla faturalanması mümkün olmadığı halde tek bir hasta için bir günde bu sayıdan fazla seans faturası düzenleyip düzenlemediği ya da tek bir takip numarası altında birden fazla defa 700.810 kodlu Selektif Koroner Anjiyografi işlemine alınan hasta olup olmadığının tespiti bu yöntemle yapılarak detaylara inilebilir.

Bu yöntemde Sağlık Uygulama Tebliği ya da tıbbi kurallara aykırı olacak şekilde belli sayıdan fazla işlem tekrarlarının tespiti amaçlandığından, bilhassa Kurum bilgi işlem sisteminden ihtiyaca uygun şekilde veri süzülmesine ihtiyaç duyulması hallerinde, öncelikle MEDULA'nın bu verileri otomatik olarak sınırlayıp sınırlamadığının, sınırlıyorsa sınırlamaya ilişkin programın sisteme hangi tarihten itibaren eklendiğinin ve bu hususta Kurumumuzca geçmişe yönelik bir inceleme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi ve ondan sonra detaylı incelemelere girişilmesi yararlı olacaktır.

Yöntemin uygulanması için denetlenen hastanenin bilgi işlem sisteminden faydalanılması her zaman mümkün bulunmamaktadır. Zira, SUT'ta getirilen bir sınırlamanın üzerinde işlem yapılarak bedelinin tahsil edilmesi halinde doğrudan kesinti yapılacağından bu bilgilerin denetlenen hastaneden istenilmesi "kendi açıklarını ele vermelerini istemek" anlamını taşıyacaktır. Bu nedenle bu tip sorgulamalarda Kurum bilgi işlem sisteminden yararlanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. İstenilen bilgilerin talep edilmesinde diğer yöntemlerde geçerli olan hususlar bu yöntem açısından da geçerlidir.

Örnek: "01.09.2007-31.12.2007 tarihleri arasında", "B Hastanesinde", "aynı takip numarası altında", "530.850 kodlu" "Göz Pansumanı işlemine alınıp", "günde 2 defadan fazla işlem faturalanan", "ödemesi tamamlanmış" ve "kesinti miktarı "0" olan" hastaların listesi.

Sıra No.	Hastane Adı	Hasta TCK No.	Takip Tarihi	Takip No.	İşlem Tarihi	İşlem Adedi	Hasta Adı ve Soyadı	İşlem Kodu	Durumu	İşlem Tutarı	Kesinti Tutarı
1	B	12345678	10.11.2007	2ACD28	11.11.2007	3	Ali KAYA	530.850	Dönem Sonlandırıldı	1,80	0

3.1.3.4. Branş Odaklı Denetim:

Bu yöntemin de tıbbi işlem odaklı denetimlerde olduğu gibi bilhassa inceleme konusunun belli bir tıbbi branş üzerine olduğu ya da bazı branşlarda yoğun şekilde fatura düzenleyen hastanelerin denetiminde kullanılması mümkündür. Yöntemin hareket noktası

denetlenen hastane tarafından sunulan branş hizmetlerinin ve bu branşlarda hizmet verilen vaka sayısının tespit edilmesidir. Bu konuda MEDULA sisteminde yeterli veri mevcut olup en çok sayıda hasta bakılan branşlarda hasta dosyasına ya da fatura detaylarına inmek mümkündür.

Bu yöntemin en önemli üstünlüğü Kurum bilgi işlem sisteminden ayrıca bir veri talebini gerektirmemesidir. Ayrıca herhangi bir nedenle denetim mahallinden kesin olarak ayrılmak gerektiğinde incelemeler eş zamanlı olarak sonlandırılabilir. Bununla birlikte, incelemelerin geniş bir tıbbi bilgiye ihtiyaç göstermesi, bu bilgilerin edinilmesi ve intibakının zaman alması, incelenen branşta bilgisine başvurulacak uzman hekimlerin her zaman bulunmaması, herhangi bir branşta ne tarz bir suiistimal aranacağını işaret etmemesi ve aynı branşta çok farklı suiistimal örnekleri ile karşılaşılabileceğinden elde edilen verilerin sürekli olarak tasniflenmesine ihtiyaç duyması yöntemin en önemli dezavantajlarıdır.

3.1.3.5. Hasta Dosyası Üzerinden Denetim:

Bu yöntemde herhangi bir serviste yatan ya da herhangi bir poliklinikte tedavi hizmeti alan kişilerle ilgili olarak tanzim edilen ve hastaya uygulanan her türlü tıbbi işleme ilişkin belgeleri içermesi gereken hasta dosyaları alınır ve gerek tıbbi işlemler gerekse mali boyutu yönünden irdelenir. Hasta dosyaları gerek inceleme gerekse soruşturmalarda temel dayanak noktası ve delili teşkil ettiklerinden özel bir öneme sahiptir. Zira bu dosyalarda teşhise esas olan bulgular, hasta yakınması, hekimin fizik muayene bulguları, tetkik- tahlil sonuçları vb. bilgiler bulunur. Dosya incelenirken; hastanın tanı ve tedavisi arasında uyumsuzluk olup olmadığı, gerek tür gerek adet olarak faturada yer alan işlemlerin yapıldığı hususunda dosyada bir kayıt bulunup bulunmadığı, fatura düzenlenen hastanın dosyanın sahibi ile aynı olup olmadığı vb. hususlara özellikle dikkat edilir.

Yöntemin hareket noktası uygun hasta dosyalarının seçimi olduğundan, bu seçimi yapmadan önce hangi branşın/servisin inceleneceğine karar verilmesi, fatura ile karşılaştırma yapılacaksa

hangi hastaların ücretli tedavi gördüğü, hangilerine sunulan sağlık hizmetlerinin Kurumumuza fatura edilmediği gibi hususlarda bilgi edinilerek bunların elenmesi gerekmektedir. Öte yandan, çoğu hastanede, hastaların dosyalarını alarak hastaneden ayrılması nedeni ile dosya bulunamaması, bazı hastanelerin dosyalarını elektronik ortamda tutması nedeni ile yazılı pek çok belgenin dosyaya konulmaması ya da tanzimindeki düzensizlikler nedeni ile hasta dosyasında bulunması gerekli birçok belgenin farklı birimlerden elde edilmesinin gerekmesi, hatta bu bilgilerin hiç bulunamaması gibi zorluklar da yaşanabilmektedir. İlk bakışta uygulama yönünden basit gibi gözüken bu yöntemde de tıpkı branş odaklı denetimlerde olduğu gibi geniş bir tıbbi bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle daha çok, fatura ile karşılaştırma yapılması amaçlandığında kullanılması uygundur.

3.1.3.6. Konu Odaklı Denetim:

Bu yöntem daha ziyade hastanelerin genel amaçlı denetimlerinde kullanılabilecek bir yöntem olup büyük ölçüde müfettişin inisiyatifine bağlıdır. Yöntemin hareket noktası, denetime ön hazırlık evresindeki incelemeler kapsamında Kurumumuz ya da hastalar açısından risk taşıyan ve denetiminde fayda görülen konuların belirlenmesidir. Denetimin bundan sonraki aşamalarının sıhhati ve denetim alanlarının takdir edilmesindeki isabet büyük ölçüde ön hazırlık evresindeki çalışmaların kalitesine bağlı olduğundan bu aşamaya özel bir önem verilmelidir. Denetimde riskli noktalar bir defa belirlendikten sonra müfettiş tarafından belli konular üzerine odaklanılarak detaylı inceleme safhasına geçilebilir.

Yöntemin iki önemli dezavantajı ön hazırlık evresinde yaşanan zaman kaybı ve riskli denetim alanlarının takdirinde bir isabetsizlik olması halinde denetim sonucunda herhangi bir bulguya erişilememe ihtimalidir. Ancak iyi bir ön hazırlık devresinden sonra son derece çarpıcı ve etkili sonuçlara ulaşmak da mümkündür.

Örnek: İyileştirici nitelikteki sarf malzemelerinin faturalandırılma usulünün araştırılması.

Örnek: İthal edilen tıbbi malzemelerin fiyatlarının belirlenmesinde Kurumumuzu zarara sokan herhangi bir uygulama olup olmadığının araştırılması.

Örnek: Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan nicel sınırlamaların MEDULA'ya ne ölçüde aktarıldığının araştırılması.

3.1.3.7. Mevzuat Odaklı Denetim:

Bu yöntemde hastane denetimi hususunda yararlanılabilecek ve ilgilileri bağlayıcı nitelikteki mevzuat hükümleri - başta Sağlık Uygulama Tebliği olmak üzere - tespit edilerek bu hükümlerin uygulanışı denetlenir. İyi bir hazırlık devresi ve buna bağlı olarak zaman gerektiren bu yöntemin uygulanışı da oldukça basittir. Bu denetim yöntemi yukarıda yer alan tüm denetim yöntemlerinin de bir aşamasını teşkil eder.

Salt kelime anlamında uygulandığında sınırlı ölçüde etkili sonuçlara ulaşma imkânı veren bu yöntemde etkili sonuçlara ulaşabilmek için diğer denetim yöntemleri ile birlikte uygulanması zorunludur.

Örnek: Hastanenin ruhsatında yer alan bilgilerin kontrol edilmesi.

Örnek: Sağlık yardımından yararlanan kimselerin müstahaklık durumunun kontrol edilmesi.

3.1.3.8. Çapraz Sorgulamalar:

Çarpıcı ve etkili sonuçlara ulaşma açısından avantajı en yüksek denetim yöntemi olan bu yöntemin hareket noktası, birbirini sınırlayan iki mevzuat hükmünün, belgenin veya bilginin uygulanması sonucunda elde edilen verilerin toparlanarak birbirleri ile karşılaştırılmaya hazır hale getirilmesidir. Uygulama öncesinde ciddi bir ön hazırlık devresi gerektiren bu yöntemde, gerekli verilerin toparlanması ve elde edilen verilerin sıhhatinin kontrol edilmesi

büyük bir önem taşımaktadır. Yöntem gerek hastane içindeki kayıtların gerekse bilgi işlem sistemindeki verilerin karşılaştırılması şeklinde yapılabilir.

Yöntemin uygulanması esnasında karşılaşılabilecek en önemli zorluklardan biri, gerekli verilerin toparlanması için çoğunlukla bilgi işlem sistemlerine ihtiyaç duyulmasıdır. Bilhassa Kurum sisteminden veri çekilmesini gerektiren durumlarda, hem sistemi gereksiz yere yormamak hem de yanlış kanaatlere sürükleyebilecek hatalı verilerin gönderilmesini engellemek için istenen veriler olabildiğince tanımlanmalı, sınırlandırılmalı ve açık şekilde ifade edilmelidir.

Örnek: Hastaya ameliyat esnasında kullanıldığı ileri sürülerek Kurumumuza fatura edilen malzemelerin ameliyat defterinde yer alıp almadıklarının araştırılması.

Örnek: Hastalara EUROSCORE ya da Kardiak Risk Puanlaması kriterleri çerçevesinde verilen ilave risk puanlarının dosyalarla karşılaştırılması.

Örnek: 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında A Hastanesi'nden sağlık hizmeti alan GSS kapsamındaki aktif sigortalıların prim ödeme günü açısından sağlık yardımına müstahak olup olmadıklarının incelenmesi.

Örnek: 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında A Hastanesi'nde vefat eden hastaların ölüm tarihlerinden sonra kendilerine reçete yazılıp yazılmadığının araştırılması.

Örnek: SGK'ya fatura edilen malzemelerin temin edildiği firmaların Kamu İhale Kurumunca yasaklı olup olmadıklarının ya da bu malzemelerin Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilen malzemelerden olup olmadıklarının araştırılması.

Örnek: SUT eki listelere göre bir arada fatura edilemeyecek işlemlerin birlikte faturalanıp faturalandırılmadığının araştırılması.

Örnek: Diyaliz cihaz adedi ve seans süresi itibarı ile tedaviye alınması mümkün olan maksimum hasta sayısı ile fatura düzenlenen diyaliz hasta sayısının karşılaştırılması.

Örnek: Kurumumuzca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurulları tarafından sigortalılara verilen işgöremezlik belgeleri ve hizmet akdi ile çalışanlar için çalışabilir kağıtları hususunda hastane ile Kurum kayıtlarının karşılaştırılması

3.2. Ön Hazırlık ve Denetim Stratejisinin Belirlenmesi

Hastane denetimlerinin ön hazırlık süreci bir anlamda denetim işlemlerinin yarısını teşkil etmektedir. Denetimin sonraki safhalarında yapılacak işlemlerin ve varılacak kanaatlerin sıhhati, denetim gerektiren riskli noktaların takdirinde isabet sağlanması ve etkili sonuçlara ulaşılması, görevlendirme süresine sadık kalınması gibi hususlar büyük ölçüde ön hazırlık safhasında yürütülen çalışmaların kalitesine bağlıdır. Bu nedenle ön hazırlık safhası zaman kaybı gibi görülmemeli, tam tersine ileride yaşanabilecek zaman kayıplarının engellenmesi ve denetimin amacına ulaşmasının garanti altına alınması için özel bir önem atfedilmelidir.

Ön hazırlık safhasında yapılması gereken işlemler ve dikkate alınması gereken hususlar kronolojik bir sıra izlenerek şu şekilde özetlenebilir:

Hastane denetimleri hususunda her müfettişe görevlendirme yapılabileceği düşünülerek, öncelikle konu ile ilgili mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete, Kurumumuzun internet ve intranet sayfaları ya da elektronik ortamda oluşturulan e-posta grupları aracılığı ile takip edilmeli, kâğıt ortamında temin edildi ise düzgün şekilde dosyalanmalı, mümkün ise Excel ya da Word programları ile oluşturulacak bir fihrist çizelgesinde izlenmelidir. Bu izleme yapılırken, bilhassa değişiklik getiren düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihler ve değişiklik getirdikleri eski düzenlemeler hususunda fihristlere ya da elektronik dosya isimlerine tarih bilgisi girilmelidir. Bu şekilde, bir yandan incelenen döneme ait işlemlerin o dönemin

cari mevzuatı açısından değerlendirilmesi sağlanırken bir yandan da denetim isteminin içeriği ne olursa olsun, konu ile ilgili mevzuatın her seferinde yeniden araştırılması ve güncelliğinin sağlanması için zaman harcamaya gerek kalmayacaktır.

Ön hazırlığın ikinci aşaması denetim gerekçesinde yer alan bilgi ve belgelerin dikkatli ve detaylı bir şekilde analiz edilmesidir. Bu aşamada;

- Denetim isteminin belli bir konuyu mu işaret ettiği (belli bir tıbbi işlem, branş, doktor vb.) yoksa genel bir mahiyeti mi olduğu (A Hastanesi'nin iş ve işlemleri, B Hastanesi'nin faturaları vb.),

- Denetim görevi için bir süre sınırı konulup konulmadığı, konulmuş ise sürenin bitimine ne kadar zaman kaldığı, kalan sürenin resmi tatil, hizmet içi eğitim vb. nedenlerle bölünüp bölünmeyeceği, eldeki iş durumuna göre denetim faaliyetine ne zaman başlanabileceği, oluşabilecek aksaklıklar için durumdan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nı hemen haberdar etmeye gerek olup olmadığı,

- Denetlenecek hastanenin nerede olduğu, yerinde yapılacak bir denetime mi yoksa Kurum birimlerinde ve masa başında yapılacak bir denetime mi ihtiyaç duyulacağı, denetim mahalline ulaşım sorunu olup olmayacağı (uçakla seyahat gerektirdiği için izin almaya gerek olup olmadığı, vb.),

- Denetim gerekçesinde yer alan belgelerin nelerden ibaret olduğu ve hangi bilgileri içerdiği, eksik evrak olup olmadığı, istenmesi gereken ilave bilgi ve belgelerin neler olduğu ve hangi birimlerden istenilmesi gerektiği,

- Düzenlenecek raporda kesin olarak hangi hususların belirtilmesi gerektiği,

Sorularının yanıtlanması gerekir.

Üçüncü aşamada, denetime başlamadan önce elde bulunması gerekli belgeler (eksik evrak, hastane sözleşmesi, ödeme belgeleri vb.) temin edilir, konu ile ilgili mevzuat derlenip okunur, gerekirse kısa özetler çıkarılır ya da önemli noktalar altı çizilerek belirtilir. Denetim yapılacak konunun mahiyetine göre internet üzerinden ya da konunun uzmanları ile görüşülerek teknik bilgi edinilir (tıbbi işlemlerin mahiyeti, uygulama endikasyonları, tıbbi malzeme hakkında bilgiler, malzemenin ithalatçı/bayi/fiyat bilgileri vb.).

Son aşamada ise, elde edilen bilgilere göre denetimde nasıl bir yöntem izleneceği, konunun hangi açılardan ele alınarak irdeleneceği ve kapsamının nasıl sınırlandırılacağı, denetimin esnasında yapılacak işlerin hangi sırada yapılacağı, hangi faaliyetin ne kadar sürede yapılacağı, birden fazla müfettiş tarafından yürütülecek işlerde iş bölümü yapılmasının mümkün olup olmadığı, mümkün ise kimin hangi konuların denetiminden sorumlu olacağı, raporlamanın nasıl yapılacağı gibi hususlarda karar verilerek bir denetim planı ve stratejisi oluşturulur.

Denetimin planı ve stratejisi, denetlenecek hastanenin çalışma tarzına, elde edilebilecek bilgilerin mahiyetine, çalışma ortamına ve benzeri faktörlere göre değişebileceğinden, planlama ve stratejiyi belirleme aşamasının mahallinde yapılacak incelemeler sonrasına bırakılması da mümkündür.

3.3. Genel Bilgilerin Temini

Hastane denetimlerine başlanıldığında denetlenen birimin yerinde görülerek çalışma imkânlarının gözden geçirilmesi, hastanenin fiziki ortamının, çalışma düzeninin ve örgütleniş tarzının anlaşılması, denetim esnasında muhatap olunacak hastane ve birim sorumluları ile tanışılması, mümkünse hastane yönetimi ile bir bilgilendirme toplantısı yapılması, bu toplantıda ayrıntıya girmeksizin genel denetim içeriğinin açıklanması, müfettişe sağlanabilecek çalışma imkânlarının görülmesi ve gerekli ortamın sağlanması, denetimin sonraki aşamalarının sıhhatli bir şekilde yürütülmesi hususunda avantaj sağlayacaktır.

Bu esnada denetimin genel çerçevesinin belirlenmesi ve ileriki aşamalarında faydalanılması için temininde fayda olduğu düşünülen bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

- Hastanenin kuruluş ve Kurumumuzla sözleşme imzalama tarihi, adres ve telefonları,

- Kurumumuzla imzaladığı sözleşmenin kapsamı,

- Kaçıncı basamakta yer aldığı, türü (resmi, özel, genel dal, özel dal, eğitim ve araştırma, üniversite) ve ruhsatında belirtilen yatak sayısı,

- Bulunduğu çevredeki durumu (aynı kategoride başka hastane bulunup bulunmadığı, çevreye ulaşımı, müşteri/hasta profili vb.),

- Hastanenin sevk ettiği ve sevkli olarak kabul ettiği hasta sayısı,

- Hastanede kullanılan bilgi işlem otomasyon programının özellikleri, hangi verilerin istenmesine müsait olduğu,

- Hastanenin bulunduğu bölge yönünden bağlı ya da muhatap olduğu ve denetim esnasında bilgi alınmasına gerek duyulabilecek sağlık müdürlükleri ve sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin müdürleri ve erişim bilgileri,

- Denetimin konusuna bağlı olarak Kurumumuzun bilgi işlem sisteminden hangi verilerin nasıl temin edilebileceği, bilgilerin temininde herhangi bir sıkıntı olup olmayacağı,

- Denetimin süresi ve mahiyeti göz önünde bulundurularak, ilgili müfettiş tarafından temininde fayda olduğu düşünülen diğer bilgiler.

3.4. Tıbbi ve İdari Birimler Hakkındaki Bilgilerin Temini

Denetlenecek hastane hakkındaki genel bilgiler temin edildikten sonra, denetimin süresi ve kapsamı da göz önünde bulundurulmak sureti ile, hastanenin iç işleyişinin daha iyi anlaşılması açısından tıbbi ve idari birimlerle ilgili daha detaylı bilgilerin temininde fayda bulunmaktadır. Bu bilgilerin bir kısmı MEDULA üzerinden edinilebileceği gibi hastanedeki birimlerin gezilerek yerinde görülmesi ya da bilgi istenmesi şeklinde de temini mümkündür.

Bu aşamada temininde fayda görülen bilgiler şu şekilde özetlenebilir:

- Tüm tıbbi ve idari birim/servislerin sorumluları ve erişim bilgileri (telefon, faks, vs.),
- Çalışan personelin unvanları itibarı ile sayıları (doktor, hemşire, diğer personel vb.),
- Hastanede teşhis ve tedavi hizmeti sunulan branşlar,
- Her branş itibarı ile teşhis ve tedavi hizmeti verilen ayaktan ve yatan hasta sayısı,
- Tüm birimlerin görev alanları, sorumlulukları ve çalışma düzenleri.
- Özellikle tıbbi birimlerde tutulan kayıtların türleri ve kayıt düzeni, kayıt düzeninde aksaklık olup olmadığı,
- Bilgi işlem sisteminden ya da birimlerden hangi bilgilerin nasıl temin edileceği, istenen bilgilerin bulunması yönünden bir sıkıntı doğup doğmayacağı,
- Denetimin süresi ve mahiyeti göz önünde bulundurularak, ilgili müfettiş tarafından temininde fayda olduğu düşünülen diğer bilgiler.

3.5. Fatura ve Kesintiler Hakkında Bilgilerin Temini

Bu aşamada denetlenen hastane tarafından Kurumumuz adına sunulan sağlık hizmetlerinin fatura edilmesindeki aksaklıklar irdelenir, teşhis ve tedavi hizmetlerinin parasal tutarı tespit edilir, bu tutarın ne kadarının Kurumumuzla ihtilaflı olduğu ve ihtilaf nedenleri sorgulanır. Bu konudaki tetkiklerde MEDULA sistemi temel bilgi kaynağı ve hareket noktası olmakla birlikte, MEDULA üzerinde herhangi bir istatistik programı bulunmadığından hangi kesinti gerekçesi ile ne kadar kesinti yapıldığı hususunda bilgi edinmek için yine Kurumumuz bilgi işlem sisteminden istatistikî veri talebinde bulunmak gereklidir.

Yine bu aşamada yapılmasında fayda bulunan bir başka işlem, denetlenen hastanenin faturalamadan sorumlu birimleri ile görüşerek Kurumumuza gönderdikleri hangi faturadan hangi nedenle kesinti yapıldığı, faturalanmasında sorun yaşadıkları herhangi bir işlem bulunup bulunmadığı, sağlık sosyal güvenlik merkezlerindeki fatura kontrol komisyonları ile daha çok hangi konularda anlaşmazlık yaşadıkları, MEDULA sisteminin hangi yönlerden yetersiz kaldığı gibi hususlarda bilgi edinilmesi ve örneklendirilmesidir. Bu sayede Kurumumuz sağlık ödemelerinin takibinde gittikçe daha büyük bir rol oynayan bilgi işlem sistemlerinin uygulamadaki etkinlik ve verimliliği de test edilmiş olacaktır.

Edinilen verilerin çapraz kontrolü için Kurumumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki Fatura Kontrol Komisyonlarından da aynı konularda bilgi edinilerek karşılaştırılmasında fayda bulunmaktadır.

3.6. Hastane Denetimlerinde Kurum Bilgi İşlem Sisteminden Yararlanma

3.6.1. Karşılaşılan Zorluklar:

Görevlendirmenin kapsamına göre değişmekle birlikte, hastane denetimleri esnasında çok farklı denetim konularında veri

temini gerekebilmekte, bu verilerin temini ve analizinin emek yoğun bir biçimde yapılması ise zaman kaybına neden olduğu gibi, kişisel hatalardan kaynaklanan nedenlerle raporların güvenilirliğinin sorgulanır hale gelmesi ihtimalini de yükseltmektedir. Bundan ötürü hastane denetimlerinde başta MEDULA olmak üzere Kurumumuzun bilgi işlem sisteminde yer alan farklı program ve uygulamalardan faydalanılması bir zorunluluk halini almaktadır.

Bununla birlikte, müfettişlerce yürütülecek hastane denetimlerinde ihtiyaç duyulacak her verinin Kurum bilgi işlem sisteminden yine müfettişlerce istenilen biçim, kalite ve sürede temini mümkün olamamaktadır. Bu durumun nedenleri şöyle sıralanabilir:

Öncelikle, her bilgi işlem sisteminde olduğu gibi Kurumumuzun bilgi işlem sistemlerinin kapasitesi de sınırsız değildir. Ülkemizin tamamına sosyal güvenlik hizmeti sunmakla yükümlü bulunan Kurumumuzun faaliyet alanlarına sosyal sigortacılık, sağlık ve sosyal yardımlar ile yardımcı hizmetler kapsamında tahsis işlemleri, ilişiksiz belgesi ve borcu yoktur yazısı verilmesi, personel maaş ve ödemeleri, sağlık yardımlarının takibi ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları yönetimi, inşaat ve evrak işlemleri gibi pek çok eylem girdiği ve bu işlemlerin büyük bir kısmı bilgi işlem ortamında takip ve icra edildiğinden kapasite gereksinimi de hayli fazla olmaktadır. Ancak bilgi işlem altyapı yatırımlarının büyük miktarda kaynağa ihtiyaç göstermesi ve zaman alması nedeni ile bir yandan yatırımlar sürdürülerek kapasite artırımına çalışılırken diğer yandan da eldeki kapasitenin etkin biçimde kullanılmasına çalışılmakta, sistemde gereksiz yer işgal edecek ve faydası sınırlı programlardan kaçınılmaktadır.

İkinci olarak, bilgi işlem veri tabanına kaydedilen her veri, her tür kullanıcının istifade edebileceği şekilde tasniflenmemektedir. Diğer bir deyişle, Kurumumuzun faaliyet alanı ile ilgili olarak kayda alınması gerekli tüm bilgiler bilgisayar programları aracılığı ile veri ambarına kaydedilmekte, kaydedilen bu verileri kullanacak olan birimlerin genel ihtiyaçlarına göre belirlenen standart programlar aracılığı ile tasniflenip kullanıcı ekranlarına aktarılmaktadır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, hastane ödemelerinde kullanılan MEDULA'nın 2008 yılında kullanılan versiyonunda her hastaya uygulanan tıbbi işlem ve kullanılan ilaç ya da malzemelere ilişkin fatura dökümleri ayrıntılı olarak yer almakla birlikte, hastalara kullanılan ilaçların maksimum dozun üzerinde uygulanıp uygulanmadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda inceleme yapmak isteyen bir müfettiş, hem araştıracağı ilaçların isimlerini, hem de bu ilaçların prospektüslerinden hareketle maksimum doz bilgilerini belirleyecek, bundan sonra da her ilaca ilişkin maksimum doz bilgilerini ilgili daire başkanlığına göndererek belirlediği maksimum dozların üzerinde ilaç kullanılan ve Kurumumuza fatura edilen hastaların listesinin çıkarılmasını isteyecektir. Kurum bilgi işlem sisteminde bu veriyi derleyecek bir program bulunmadığından istenilen nitelikte farklı bir program yapılarak gerekli bilgiler bu program vasıtası ile bilgi işlem veri ambarından çekilecek, sonra da talep eden müfettişe gönderilecektir.

Üçüncü olarak, hastane denetimlerinde ihtiyaç duyulacak çapraz sorgulama ve istatistiksel bilgi menüleri Kurumumuz bilgi işlem sistemlerinde hazır halde bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi iki verinin kıyaslanması ya da belli bazı bilgileri özel olarak talep edecek müfettişler, bu iş için gerekli programlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Hastane denetimlerinde görev alan müfettişlerin isteyecekleri verilerin temininde bazen zaman yönü ile de sıkıntı yaşanabilmektedir. Sistem aynı anda milyonlarca veriyi kullanıp işlediği için her zaman çok yoğun biçimde çalışmaktadır. İlgili müfettişin istemi üzerine yeni bir program yapılarak veri temini amaçlandığı takdirde bilgisayar programcıları tarafından hazırlanan program sisteme girilmekte, bundan sonra müdahale imkânı olmadığı için gerekli veriler derlenip çıktı alınmaya hazır hale gelene kadar beklenilmektedir. Bu süre istenen programın ihtiyaç duyduğu verilerin genişliğine, sistemde çalışan diğer programların sayısına ve bellek kapasitesine göre değişebilmektedir. Örneğin, 2008 yılında yapılan hastane denetimlerinde, bir arada faturalanamayacak bazı

kan tetkiklerini bir arada yaparak faturalayan hastanelerin Türkiye çapında sorgulanarak zararın tespiti Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığından talep edilmiş, ancak bu bilgiyi derlemek için yaklaşık 400 milyon veriyi taraması gereken sistemin tıkandığı belirtilerek denetim çapının belli bir hastane ile sınırlandırılması istenilmiştir.

Son olarak, istenen verilerin belirlenmesi ve sınırlandırılmasındaki eksiklikler de Kurumumuz bilgi işlem sistemlerinden yararlanmayı zorlaştırmaktadır. Söz gelimi, MEDULA sisteminde takip edilen her yeni hasta başvurusunda sistem tarafından farklı olarak üretilen hasta takip numarasının bildirilmesi istenilmekle birlikte, bu numaranın MEDULA ekranındaki sayısal ve alfabetik karakterlerle (27AX3B, 3Q34B1 gibi) bildirilmesi yerine sistemin kendi mantığı ile ürettiği 00000296457429 gibi farklı bir rakam kodlaması bildirilebilmekte, bu rakamla MEDULA üzerinde hasta takip etmek mümkün olmadığından aynı verinin istenen formatta temini için yeniden yazışma yapmak gerekebilmektedir.

3.6.2. Dikkat Edilecek Hususlar:

Müfettişlerce yürütülecek olan hastane denetimleri esnasında Kurumumuzun bilgi işlem sistemlerinden yararlanmak gerektiği takdirde karşılaşılabilecek zorluklardan kaçınmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Öncelikle hangi verinin ne şekilde isteneceği kararlaştırılmalı, gönderilecek listelerde hangi başlıkların yer alması gerektiği belirlenmelidir. Gereksiz bilgilerin sistemden taranıp bulunması hem sistemi yoracak hem de talep eden müfettişe dönüş süresini uzatacaktır.

- İstenen bilgilerin formatına karar verilmelidir. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlıklarından istenen bilgiler çoğunlukla e-posta yoluyla ve Excel programında oluşturulmuş listeler halinde gönderildiğinden farklı bir formata ihtiyaç duyulacaksa bu durum önceden bilinmeli ve talepte bulunulacak birime bildirilmelidir.

- Talepte bulunulmadan önce bilginin isteneceği sorumlu daire başkanlığı ve yetkili kişi ile irtibata geçilmeli, istenen bilginin temin edilme imkânı olup olmadığı ve ne zaman temin edilebileceği teyit edilmeli, yazı ile talepte bulunulacaksa istenen bilgilerin nasıl bir listeye aktarılması gerektiği hususunda örnek bir tablo yazı ekine konulmalıdır.

Örnek: "01.09.2007-31.12.2007 tarihleri arasında", "B Hastanesinde", "4 günden az aralıkla", "530.590 kodlu" "Arter Kateterizasyonu işlemine alınan", "ödemesi tamamlanmış" ve "kesinti miktarı "0" olan" hastaların listesi.

Sıra No.	Hastane Adı	Hasta TCK No.	Takip Tarihi	Takip No.	Önceki İşlem Tarihi	Sonraki İşlem Tarihi	İşlem Aralığı (gün)	Hasta Adı ve Soyadı	İşlem Kodu	Durumu	İşlem Tutarı	Kesinti Tutarı

- Şayet bir kısım veriler önceden müfettiş tarafından belirlenerek bunlarla bağlantılı başka veriler istenecekse, bildirilecek verilerin yeterli olup olmadığı ilgili birim/yetkililerle görüşülerek teyit edilmelidir.

Örnek: İsmini bildiği bazı hastalara uygulanan tıbbi işlemleri liste halinde görmek isteyen bir müfettişin bu amaçla gerekli verileri Kurum bilgi işlem sisteminden almak istemesi durumunda, sadece bu hastaların ad ve soyadlarını bildirmesi yeterli olmayıp hasta takip numarası veya TC kimlik numaralarını da bildirmesi gereklidir. Aksi takdirde sistem aynı isimdeki tüm hastaları taramak için hem daha fazla yorulacak, hem taramanın süresi uzayacak hem de ilgili müfettiş doğru hastaları bulmak için gönderilen liste üzerinde ikinci bir eleme çalışması yapmak zorunda kalacaktır.

Örnek: Eczane reçete kontrol ekranlarından herhangi bir hastanın reçete bilgilerini çekmek isteyen bir müfettişin bu hastanın sadece sağlık karne numarasını bildirmesi yeterli olmayıp bununla birlikte hastanın sicil numarasını da bildirmesi gereklidir.

3.6.3. Başvurulacak Birimler:

Bilindiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 16. maddesi gereğince; "her türlü bilişim hizmetlerinin yürütülmesi, sosyal güvenlik veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi, yazılım ve donanım altyapısının planlanması, kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi, yenilenmesi ve güvenliği ile sürekliliğinin sağlanması" Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunmaktadır. Kurumumuzun faaliyet alanları ile ilgili olarak bilgi işlem ortamında toparlanan veriler bu Genel Müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarının koordinasyonu ile derlenmekte ve geliştirilen bilgi işlem uygulamaları ile kullanıma sunulmaktadır.

Hastane denetimleri esnasında da Kurumumuzca kullanılan çok farklı bilgi işlem uygulamalarından faydalanmak gerekebilmektedir. Bu faydalanma kimi zaman ilgili Müfettişin sisteme "kullanıcı" olarak girmesi, kimi zaman ise belli verilerin analiz ve tasnifine yönelik olarak ilgili daire başkanlıklarından talepte bulunulması şeklinde gerçekleşebilir. Ancak gerek kullanıcı adı ve sisteme giriş yetkilerinin talep edilmesi, gerekse ihtiyaç duyulan bilgilerin talep edilmesi aşamasında muhatap olarak alınacak birimlerin doğru şekilde belirlenebilmesi için Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü içindeki yapılanma ve görev ayrımının bilinmesi gerekmektedir. Bu husustaki bilgiler güncel halleri ile www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanmakta olup ihtiyaç halinde bu adresten temin edilebilir.

Hastane denetimi yönünden ihtiyaç duyulabilecek bazı sistem giriş yetkileri ile temin edilebilecekleri daire başkanlıkları aşağıda sunulmuştur:

Daire Başkanlığı	Talep Edilebilecek Yetkiler
Yazılım Geliştirme ve Sistem	Sınırsız internet, Elektronik posta adresi, Kimlik Paylaşım Sistemi Sorgulama, Intranet Sigortalı Tescil İşlemleri, Bağ-Kur ekranından gelir vergisi mükellefiyeti sorgulama yetkisi Aylık Prim Hizmet cetveli, İntranette tarım sigortası işlemleri, Cıcs evrak uygulamaları, Cıcs hastalık ve iş kazası uygulamaları, Cıcs ve intra yurtdışı uygulamaları, Cıcs isteğe bağlı işlemleri, e-bildirge başvuru, İşyeri hekim yetkisi
Teknoloji ve İş Geliştirme	İntranet Evrak Kayıt ve Takip, Eczane Reçete Kontrol, MEDULA, MEDULA Optik, Veri Ambarı, Sağlık Karnesi Görüntüleme, Intranet Sağlık Ödemeler Sistemi (İşgöremezlik Rapor Kullanıcı), Intranet Sağlık Ödemeler Sistemi (Protez Hasta Cihaz Takip Genel Kullanıcı)

3.6.4. Faydalanılabilecek Bilgi İşlem Sistemleri:

3.6.4.1. MEDULA:

MEDULA, MED(ikal) ULA(k) kelimelerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile isimlendirilen, ülke genelindeki Kurum sağlık harcamalarının takibi ve sağlık finansman politikalarının geliştirilebilmesi amacı ile tüm sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti kullanım verisini toplamak ve gerekli geri ödemeleri yapabilmek amacı ile oluşturulan bir bilgi işlem sisteminin genel adıdır. Sistem 25.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer almış olup, özel sağlık tesisleri için 15.06.2007, devlet ve üniversite hastaneleri için ise 01.09.2007 tarihi itibari ile kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Sistem; sağlık hizmet sunucularının iç işleyiş süreçlerine en az müdahalenin yapılmasını, tüm sağlık hizmet sunucularını kapsayan bütünleşik bir sistem kurulmasını, entegrasyonun her tür hizmet sunucu açısından kolay ve düşük maliyetli olmasını ve hem hizmet sunucular hem de Kurumumuz açısından sürdürülebilir olmasını hedeflemekte olup, sağlık hizmet sunucuları ile Kurumumuz arasında dört temel bilgi akışı üzerine kurulu bir iş modeli çerçevesinde inşa edilmiştir. MEDULA'nın üzerine inşa edildiği bu dört temel süreç; "hak sahipliği ve sözleşmenin doğrulanması", "başka bir sözleşmeden kullanım talebinin yapılması", "sunulan hizmetler için geri ödeme talebi (ödeme sorgusu)" ve "faturalama" olarak özetlenebilir.

Hastaneye başvuran hastalar için sistemin adım adım işleyişi ana hatları ile şu şekilde özetlenebilir:

Hastalar mevzuatta belirtilen belgelerle birlikte sağlık hizmeti almak için MEDULA'ya dâhil olan bir sağlık tesisine başvurduklarında, sağlık tesisine kaydedilerek hak sahibi olup olmadıklarının anlaşılması için T.C. kimlik numarası ve tesis kodu belirtilerek web ortamında Kurumumuza (MEDULA) bildirilmektedir. Sistem sağlık tesisinin sözleşmesi olup olmadığını, hastanın ise hak sahibi olup olmadığını denetlemekte ve sonuç olumlu ise alfabetik ve numerik karakterlerden oluşan bir takip numarası üreterek (3Q3A45 gibi) yine web ortamında sağlık tesisine bildirmektedir.

Hastaya bundan sonra sağlık tesisi içinde sunulan tüm sağlık hizmetleri bu takip numarası altında izlenmekte ve hastanenin bilgi işlem sisteminde toplanmaktadır. Bundan sonraki aşamada hastaya verilen tüm hizmetler listelenerek ödeme sorgusu yapılmak üzere web ortamında Kurumumuza bildirilmektedir.

MEDULA sistemi gönderilen hizmetler listesini bilgisayar programcıları tarafından sisteme tanımlanan sınırlamalar yönünden kontrol ederek (işlem kodu ile tanımının birbirine uygunluğu, bir günde yapılabilecek maksimum işlem adedi, işlemi yapan doktorun hastanede görevli olup olmadığı, vb.) ödenebilecek ve ödenemeyecek işlemleri sağlık tesisine web ortamında bildirmektedir.

Sağlık tesisi kendisine gelen bilgilere göre faturada gerekli düzeltmeleri yapıp tüm fatura metnine onay aldıktan sonra belli bir tarih aralığında sağlık hizmeti sunulan tüm hastalara uygulanan ve ödeme onayı alan işlemler için sanal ortamda fatura hazırlayıp Kurumumuza göndermektedir. MEDULA, bu sanal faturalar üzerinde son kontrolleri yapıp onayladıktan sonra bir fatura teslim numarası oluşturarak sağlık tesisine bildirmekte, ayrıca bildirilen tüm işlemleri "Faturalandı" olarak işaretlemektedir.

Sağlık tesisi bu numarayı öğrendikten sonra sanal ortamda dönem sonlandırması yaparak bu döneme sonradan fatura eklenmesini engellemekte ve yine sanal ortamda örnekleme sürecini başlatmaktadır. Bilahare ise sistem tarafından örnek olarak seçilen hastalara ait faturalar kâğıt ortamına dökülerek kontrol edilmek üzere sağlık sosyal güvenlik merkezlerine teslim edilmektedir.

3.6.4.2. GSS Sağlık Kontrol Sistemi (Eczane):

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası ile T. C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın birleştirilmesi sonrasında Kurumumuzun eczane ve reçete işlemleri ile ilgili olarak GSS Sağlık Kontrol Sistemi (Eczane) isimli ortak bir sistem kullanıma açılmış olmakla beraber, T. C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur reçeteleri için siyah ekranlı kapalı sistemler, 2007 öncesi SSK reçeteleri için ise Eczane Provizyon Sistemi (İl Yöneticisi)-SSK (Devredilen) gibi sistemler de bilgi alma ve geçmişe dönük denetim amaçlı olarak halen kullanımdadır.

Eski sistemlere giriş için kullanıcı kodu ve giriş yetkileri Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığınca, GSS Sağlık Kontrol Sistemi (Eczane) giriş için kullanıcı kodu ve giriş yetkileri ise Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığınca sağlanmakta olup, halen kullanılan sisteme Kurumumuz intranet sisteminden ya da http://eczane.sgk.gov.tr/skos/ adresi aracılığı ile internetten erişilebilmektedir.

Söz konusu sistem kullanılarak sözleşmeli eczaneler ile ilgili olarak eczane sicili ve eczane adı gibi bilgilerin yanında T. C. Emekli

Sandığı, Bağ-Kur ve SSK ile diğer genel sağlık sigortalıları ile ilgili seçim yapılmasını müteakip, eczane bazında reçete kontrol ve ödeme durumu, ilaç bilgileri ve hak sahibi bazında ilaç, rapor, katkı payı, MEDULA muayene takipleri ile ilgili bilgilere de erişilebilmektedir.

3.6.4.3. Veri Ambarı :

Verinin bilgiye dönüştürülmesi, bilginin yönetilmesi ve paylaşılması sürecinde veri ambarı önem taşımaktadır. Kurumumuzun tüm operasyonel sistemlerinde oluşan verilerin tek bir yapıda toplanacağı veri ambarından sağlık ödemelerine ve işlemlerine ait veriler ile raporların analiz edilerek denetim sürecinin oluşturulması ve tamamlanması sağlanabilir. Sistemin sağlık işlemlerinde Teftiş Başlığı altında "Eczane/Hastane Kayıt Dökümü", "Ödenmiş faturalar eczane/hastane", "Ödenmemiş fatura eczane/hastane", "Malzeme kayıtları dökümü" verilerinden yararlanılmalıdır.

3.7.Tıbbi Birim Denetimlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

3.7.1. Genel Suiistimaller:

Denetlenen hastanelerde kurulu bulunan servis, poliklinik ve laboratuar gibi tıbbi birimlerde üretilen sağlık hizmetlerinin satın alınmasında genel olarak şu usulsüzlüklerle karşılaşılmaktadır.

- Endikasyonsuz tıbbi ya da cerrahi girişimlerde bulunulması,
- Tetkik ve tahlillerin teşhis ya da tedavi için gerekenden fazla sayıda ya da türde yapılması,
- Anestezi tipi, kesi bilgisi, kullanılan ilaç adı ve miktarı, kullanılan malzeme bilgisi gibi fatura bedelinin artışında önemli rolü olan bilgilerin kasıtlı ya da kasıtsız olarak eksik veya yanlış olarak kaydedilmesi,
- Hasta yatış sürelerinin fazla gösterilmesi,
- Ameliyat sonrası komplikasyonlara ilişkin sahte/yanlış kayıt düzenlenmesi,

- Tedavinin Kurum'a bildirilen hekimin dışında hekim tarafından yapılması,
- Ruhsatsız ve/veya lisansız birim ve cihazlarla tedavi yapılması,
- Sterilize edilerek tekrar tekrar kullanılabilen (reuse) malzemelerin her defasında ilk kez kullanılmış gibi gösterilmesi,
- İlgili yıl sağlık uygulama tebliğinde belirtilen rapor düzenleme ve tedavi şartlarına uyulmaması,
- Sağlık kurulu raporlarının yetkili hekimlerce tanzim edilmemesi.

Ayrıca, bazı tıbbi branşlara yönelik olarak karşılaşılan usulsüzlükler ile tespit edilme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

3.7.2. Kardiyoloji:

1) Kardiyoloji algoritma (Kardiyoloji biliminin genel esaslarına göre kabul görmüş teşhis ve tedavi aşamalarıdır.) kurallarına aykırı olarak yersiz koroner anjiyografi tetkiki yaptırılması.

(Sonucu normal çıkan anjiyografi işlemlerinin çekilen anjiyografi işlemlerine oranının % 20'den fazla olması halinde ilgili hastane incelemeye alınmalıdır.)

2) Her üç koroner arterde üst seviyede ve yüksek oranda lezyon bulunduğu ve doğrudan koroner by-pass işlemi yapılması gerektiği hallerde, yersiz koroner anjiyoplasti (PTCA) ve stent uygulanması, daha sonra da koroner by-pass ameliyatı yapılması.

(Hasta dosyasından hastaya yapılan tüm teşhis ve tedaviye ilişkin işlemler ile uygulanan cerrahi işlemler incelenmelidir.)

3) Non dominant RCA (çalışmayan) kılcal damara balon veya stent uygulanması.

(Koroner anjiyografi CD ve raporu incelenmek sureti ile anlaşılır.)

4) Lezyon boyuna uygun bir stent yerine birden fazla stent konulması.

(Koroner anjiyografi CD ve raporu incelenmek sureti ile anlaşılır.)

5) Aynı seans içerisinde birden fazla işlem (koroner anjiyografi+PTCA+stent) yapıldığı halde ayrı seanslarda yapılmış gibi fatura edilmesi.

(Hasta dosyası ve koroner anjiyografi raporu ile işlem CD'si incelemek ve hastadan alınan bilgilerle karşılaştırmak sureti ile tespit edilebilir. İncelenen kayıtların tamamının (işlem CD'si dâhil) sahte olabileceği dikkate alınarak, ifadeler esnasında hastalara işlem masasına kaç defa yattıklarının açıkça sorulması ve net cevap alınması, ayrıca ellerinde bulunan belge ve CD'lerin hastanelerden alınan dokümanla karşılaştırılması tavsiye edilir.)

6) Aynı seans içinde birden fazla koroner damara müdahale edildiği halde farklı seanslarda yapılmış gibi fatura edilmesi.

(Hasta dosyası ve koroner anjiyografi raporu ile işlem CD'si incelemek ve hastadan alınan bilgilerle karşılaştırmak sureti ile tespit edilebilir. İncelenen kayıtların tamamının (işlem CD'si dâhil) sahte olabileceği dikkate alınarak, ifadeler esnasında hastalara işlem masasına kaç defa yattıklarının açıkça sorulması ve net cevap alınması, ayrıca ellerinde bulunan belge ve CD'lerin hastanelerden alınan dokümanla karşılaştırılması tavsiye edilir.)

7) Hasta dosyalarında yer alan ve 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin "19.9. Kardiak Risk Skorlaması" başlıklı bölümünde belirtilen kriterlerin gerçeğe dayanmaması.

(Hasta dosyalarında yer alan bilgilerin teyit edilerek Kardiak Risk Skorlaması kriterleri ile karşılaştırılması ile anlaşılabilir.)

3.7.3. Kardiyovasküler Cerrahi (KVC):

1) Çalışan kalpte (Beating Heart) kardiyopulmoner cihaz kullanmaksızın ameliyat yapıldığı halde, açık kalp kardiyopulmoner cihaz kullanmak sureti ile ameliyat yapılmış gibi rapor ve fatura düzenlenmesi.

(Hasta dosyasındaki ameliyat bilgileri, anestezi belgesindeki miktar ve süreler ile kullanılan heparin (kan sulandırıcı) miktarlarından anlaşılabilir.)

2) Mitral kapak ameliyatlarında kapağın tam kapanmayıp sistolde bir kısım kanın sol ventikülden (karıncıktan) sol atriuma (kulakçık) geri kaçırılması hallerinde kapakçığa destek için kullanılması gereken ring isimli malzemenin kullanılmadığı halde kullanılmış gibi fatura edilmesi.

(Ring malzeme zaman içinde vücut tarafından absorbe edildiğinden tespiti zordur. Ameliyat notundan ve malzemenin ithal ve satınalma belgelerinden tespit edilmesi gerekir.)

3) By-pass ameliyatlarında lima (kol) ve/veya safen (bacak) bölgesinden doğal damar alındığı ve koroner by-pass cerrahisi bu suretle tamamlandığı halde greft (suni damar) kullanılmış gibi fatura edilmesi.

(Kol ve bacakta ameliyat izi aranmalı, zaman zaman kol ve bacakta sahte ameliyat izi olduğundan şüphe edilmesi halinde kol ve bacağa doppler ve ultrasonografi çektirilmelidir.)

4) Perikard (kalbin dış zarı) doğrudan yama olarak kullanıldığı halde patch (suni yama) kullanıldığına dair fatura düzenlenmesi.

(Ameliyat notunun incelenmesi ile tespit edilebilir.)

3.7.4. Ortopedi ve Travmatoloji:

1) Femur başı kırıklarda protez takılan ve vefat eden hastalardan alınan protezlerin yeniden steril edilerek (reuse olarak) başka bir hastaya kullanılması ve malzemenin ikinci defa fatura edilmesi.

(Hasta dosyaları ve kadavra incelemesi ile belirlenebilir.)

2) Ortopedi ameliyatlarında kullanılan bazı malzemelerin ihtiyaca uygun ebadı/hacmi piyasada mevcut ve birim bedeli daha ucuz olduğu halde; toplam bedeli daha fazla olan küçük ebad ve hacimde malzemelerin kullanılarak fazla ödemeye yol açılması.

(Malzemelerin piyasa ambalaj ve fiyatları incelenip hasta dosyası ve faturalarla karşılaştırılmak sureti ile tespit edilebilir.)

3) Hastalara yerli malzeme kullanıldığı halde ithal malzeme kullanılmış gibi fatura edilmesi.

(Hastalara kullanılan malzemelerin bizzat görülmesi ya da dayanağı belgelerin faturalarla karşılaştırılması sureti ile tespit edilebilir. Ayrıca ilgili firmanın malzemeye ilişkin giriş-çıkış faturaları da adet ve bedel yönünden tetkik edilmelidir.)

4) Hastalara standart malzeme kullanıldığı halde özel yapım malzeme kullanılmış gibi fatura edilmesi

(Hastalara kullanılan malzemelerin bizzat görülmesi ya da dayanağı belgelerin faturalarla karşılaştırılması sureti ile

tespit edilebilir. Ayrıca ilgili firmanın malzemeye ilişkin giriş-çıkış faturaları da adet ve bedel yönünden tetkik edilmelidir.)

5) Diz artroz (kireçlenme) vakalarında uygulanan ve UBB'de kayıtlı enjeksiyon materyalleri yerine noltreks adlı ruhsatsız ürünün kullanılması ve fatura edilmesi.

(Epikriz belgeleri ile faturaların karşılaştırılması, kullanılmış gibi gösterilen malzemelerin ilgili firmaya giriş-çıkış kayıtlarının karşılaştırılması ya da malzemenin gerçekten kullanılıp kullanılmadığı hususunda hasta ile görüşülmesi ile anlaşılabilir.)

6) Endikasyon gerektirmediği halde firma-hekim işbirliği ile yersiz ortez reçete edilmesi. Örnek: Açı ayarlı diz ortezi.

(Hasta dosyalarındaki endikasyon bilgileri ile verilen ortezlerin karşılaştırılması ile anlaşılabilir.)

7) Konjenital primer fokomeli vakalarında (üst kol ile alt kol yok ve el bileği omuzda, üst bacak ile alt bacak yok ve ayak bileği kasıkta) ancak fizik tedavi-rehabilitasyon ve protez eğitimi ile takılabilen alt ve üst ekstremite modüler protez işlemlerinde, protez takılmadığı halde alt ve üst modüler protez bedellerinin Kurumumuzdan tahsil edilmesi.

(Hastaya ziyaret yapmakla alt ve üst ekstremite modüler protezlerin takılmadığı kolayca anlaşılır.)

3.7.5. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi:

1) Rinoplasti (estetik amaçlı) olarak yapılan ameliyatların septorinoplasti (deviasyon düzeltilmesi+estetik) olarak fatura edilmesi.

(Hasta dosyaları ve ameliyat kayıtlarının faturalarla karşılaştırılması ile anlaşılabilir. Gerekirse hasta ifadesine başvurulabilir.)

2) Estetik amaçlı yapılan mamoplasti ameliyatlarının kanser tedavisi de yapılmış gibi faturalandığı halde kanser tanısını koymayı sağlayacak hiçbir tetkikin yapılmaması.

(Hasta dosyası ve hastane kayıtlarındaki tetkik bilgilerinin faturalarla karşılaştırılması ile tespit edilebilir.)

3) Yağ aldırma (liposuction) amaçlı yapılan ameliyat bedellerinin ödenmesini sağlamak için hormonal tedavi de yapılmış gibi faturalanması, oysa bu amaçla yapılan hiçbir tetkikin olmaması.

(Hasta dosyası ve hastane kayıtlarındaki tetkik bilgilerinin faturalarla karşılaştırılması ile tespit edilebilir.)

3.7.6. Beyin Cerrahi:

Vertebralarda kullanılan ve bedelleri Kurumumuzca ödenmeyen malzemelerden olan X-stop, Spine-fix ve Coflex gibi markalardaki interspinal distraction (implant) malzemelerin ayrıca fatura edilip bedellerinin Kurumumuzdan alınması, bedeli ödenen malzemelerden olan vida, rod vb. malzemelerin ise kullanılmadıkları halde kullanılmış gibi fatura edilmesi ya da abartılı sayıda fatura edilmesi.

3.7.7. Diş Hastalıkları:

İlgili yıl sağlık uygulama tebliğinin diş tedavileri ile ilgili bölümünde ödenmeyeceği belirtilen maden ve işlem bedellerinin faturalanması.

(Tedaviye ilişkin belgelerin faturalarla karşılaştırılması ve gerekirse hastaların yeniden muayenesi ile anlaşılabilir.)

3.7.8. Nefroloji-Diyaliz:

- 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin; "19.1. ESWL Metodu İle Yapılacak Taş Kırdırma Tedavileri", "19.3. Radyo Cerrahi Yöntemleri İle Tedavi", "19.4. Ekstrakorpereal Fotoferez" ve "19.5. Diyaliz Tedavileri" başlıklı düzenlemelerine uyulmaması.

(Faturalarda ve hasta dosyalarında yer alan bilgilerin ilgili maddelerde belirtilen şartlar yönünden tetkiki ile tespit edilebilir.)

Denetimler esnasında, denetim konusu edilecek tüm branşlarla ilgili tetkiklere başlamadan önce nicel yönden, endikasyon yönünden ya da faturalama esasları yönünden suiistimale müsait ve özellikle kontrol edilmesi gerekecek hususların ilgili yıl sağlık uygulama tebliğinin tetkiki sureti ile tespit edilmesinde fayda bulunmakta olup; bu esnada tespit edilen sınırlamaların MEDULA'ya tanımlı olup olmadığının, tanımlı ise hangi tarihten itibaren tanımlandığının Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün ilgili biriminden teyit edilmesi de unutulmamalıdır.

3.8. İdari Birim Denetimlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere, Kurumumuz ile hastaneler arasındaki ilişkilerin temel boyutu sağlık hizmeti satın alınması ve karşılığında ödeme yapılması şeklindedir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan kimselere verilen bu sağlık hizmetlerinin faturalanmasında hastane bünyesinde bulunan birtakım idari birimlerin de rolü olmaktadır. Bu nedenle, hastane denetimleri esnasında denetim gerekçesinde yer alan konularla sınırlı olmak kaydı ile bazı idari birimlerin işlemlerinin de kontrol edilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu birimlerin isimleri denetlenen hastanelerdeki örgütleniş tarzına göre değişmekte ise de fonksiyonları açısından bir sınıflama yapılması mümkündür. Bu birimler arasında tıbbi malzeme, eczane, arşiv, faturalama, bilgi işlem, hasta kayıt, provizyon, karantina (hasta yatış) ve malzeme depoları (tıbbi ayniyat) birimleri sayılabilir.

Genel olarak bakıldığında, hastanelerin idari birimlerince yürütülen işlemlerle ilgili olarak başlıca şu hata ve suiistimallerle karşılaşılmaktadır:

- Yapılmayan tetkik ve tahlillerin fatura edilmesi (Tıbbi birimlerin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabileceği gibi faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından da kaynaklanabilir.),

- Mükerrer ya da SUT'a aykırı faturalama (Faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabilir.),

- Cerrahi tedavilerin üst gruptan fatura edilmesi (Tıbbi birimlerin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabileceği gibi faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından da kaynaklanabilir.),

- Anestezi tipinin farklı faturalanması (Tıbbi birimlerin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabileceği gibi faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından da kaynaklanabilir.),

- Anestezik, antibiyotik gibi ilaç sarfiyatlarının yüksek fatura edilmesi (Faturalama, hastane eczanesi ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabilir.),

- Ayrıca faturalanamayacak sarf malzemelerinin fatura edilmesi (Faturalama, malzeme ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabilir.),

- Refakatsiz yatan hastaların refakatçi kalmış gibi fatura edilmesi (Faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabilir.),

- Ameliyat sonrası enfeksiyon, komplikasyon vb nedenlerle hastaların hastanede uzun süre kalmaları (hijyenik koşulların olumsuzluğu) (Faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabilir.),

- Kullanılmayan kanların fatura edilmesi (Tıbbi birimlerin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabileceği gibi faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından da kaynaklanabilir).

- Çoklu kullanımlı malzemelerin her hastaya ayrı ayrı fatura edilmesi (Tıbbi birimlerin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabileceği gibi faturalama biriminin suiistimal ya da hatalarından da kaynaklanabilir).

- Paket tedavilerde, paket kapsamındaki tahlil ve tetkiklerin ayrıca fatura edilmesi ve paket kapsamı dışında ilave muayene, tetkik ve tahlil yapılması (Tıbbi birimlerin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabileceği gibi faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından da kaynaklanabilir).

- Tıbbi malzeme fiyatlarının yüksek şekilde faturalandırılması (Faturalama, malzeme ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabilir).

- Yüksek fiyatlı tıbbi malzemelerin fatura edilmesi (Çoğunlukla doktorlarla firmaların işbirliği neticesinde ortaya çıkan bir durum olup, bu hususta ihale bilgilerine de başvurmak gerekebilir).

- Hak sahibi olmayan kişilere kullanılan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi (Hasta kayıt (provizyon) biriminin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabileceği gibi Kurum provizyon sisteminden de kaynaklanmış olabilir).

- Tıbbi malzeme fiyatlandırılmasında hatalı kur uygulanması (Çoğunlukla malzeme temin eden firmaların suiistimallerinden kaynaklanmaktadır).

- Tıbbi malzemelerin hastalara temin ettirilmesi (Tıbbi malzeme ya da faturalama ile ilgili birimlerin hatalarından kaynaklanabilir).

- Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerine yansıtılan işletme gideri ve Hazine kesintisi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisinin doğru hesaplanmaması (Faturalama ya da bilgi işlem birimlerinin suiistimal ya da hatalarından kaynaklanabilir).

3.9. Bilgi İşlem Verilerinin Analizinde Dikkat Edilecek Hususlar

Hastane denetimleri esnasında bilgi işlem sistemleri aracılığı ile temin edilen veriler belli bir ihtiyaca göre ve belli bir formatla düzenlenmiş standart tipte veriler olup, özellikle farklı kullanıcılar tarafından sisteme girilmeleri halinde hatalı kayıtları da içerebilirler. Bu yüzden gerek bilgi talep ederken gerekse temin edilen bilgilerden yararlanırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Bilgi işlem verilerinin analizinde dikkat edilecek hususlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

- Öncelikle, denetimler esnasında yararlanmak üzere bilgi işlem isteminden veri talep edilirken gönderilecek bilgilerin hatalı ya da mükerrer veri içerme ihtimali en aza indirilmelidir. Bunun için talepte bulunulmadan önce bilginin isteneceği sorumlu daire başkanlığı ve yetkili kişi ile irtibata geçilmeli, istenen bilgilerin sistemden süzülerek alınmasında oluşabilecek mantık hatalarının bulunup bulunmadığı ve varsa mahiyeti aydınlatılmalıdır.

Örnek: 2007 SUT'un Ek-8 listesinde yer alan ve her hasta için bir defa ödeneceği belirtilen "908.820" kodlu "DNA, İzolasyon, kan*" işleminin A Üniversite Hastanesi'nde birden fazla faturalandığı hastaların listesinin talep edilmesi halinde, hasta bazında süzme işlemi yapılacağından istenen liste aşağıdaki şekilde gönderilecektir.

TESİS KODU	TAKİP NO	AD	SOYAD	İŞLEM TARİHİ	İŞLEM TUTARI	SUT KODU	ADET	KESİNTİ TUTARI
11270007	6DX02F	MUSTAFA	BAZLAMA	18.07.2008	58,74	908820	3	0,00
11270007	6DX02F	MUSTAFA	BAZLAMA	18.07.2008	39,16	908820	2	0,00
11270007	6CC8KV	KAZIM	LEYLALAR	16.07.2008	19,58	908820	1	0,00
11270007	6CC8KV	KAZIM	LEYLALAR	16.07.2008	39,16	908820	2	0,00
11270007	6CC8KV	KAZIM	LEYLALAR	16.07.2008	58,74	908820	3	0,00
11270007	6B9SD4	ALI	UGUR	14.07.2008	17,80	908820	1	0,00
11270007	6B9SD4	ALI	UGUR	14.07.2008	17,80	908820	1	0,00
11270007	6ADIP7	TULAY	YILDIZHAN	11.12.2007	19,58	908820	1	0,00
11270007	6ADIP7	TULAY	YILDIZHAN	11.12.2007	19,58	908820	1	0,00
11270007	**6JWKKX**	**NEJLA**	**SAHIN**	**30.07.2008**	**19,58**	**908820**	**1**	**0,00**
11270007	**6JWKKX**	**NEJLA**	**SAHIN**	**30.07.2008**	**39,16**	**908820**	**2**	**0,00**
11270007	**6JWKKX**	**NEJLA**	**SAHIN**	**30.07.2008**	**19,58**	**908820**	**1**	**0,00**
11270007	**6JWKKX**	**NEJLA**	**SAHIN**	**30.07.2008**	**58,74**	**908820**	**3**	**0,00**
11270007	6J4SK8	FİKRET SÜLEYMAN	BAŞARAN	29.07.2008	39,16	908820	2	0,00
11270007	6J4SK8	FİKRET SÜLEYMAN	BAŞARAN	29.07.2008	58,74	908820	3	0,00
11270007	6J4SK8	FİKRET SÜLEYMAN	BAŞARAN	29.07.2008	19,58	908820	1	0,00

Yukarıdaki listede de görüldüğü üzere, müfettiş tarafından istenen bilgi iki yönden hatalı şekilde süzülmüştür. İlk olarak, birden fazla 908.820 kodlu işlem yapılan hastaların faturalarında yer alan tüm 908.820 kodlu işlemler alt alta dizilerek hasta bilgileri mükerrer gönderilmiş; öte yandan da istenen bilgiler hastane tarafından MEDULA'ya girilen fatura verilerinden aynen alınarak listeye aktarıldığı için tetkikler toplu halde listeye alınmıştır. Bu nedenle tetkikin üniversite hastanelerinde geçerli 2007 yılı birim fiyatı olan KDV hariç 19,58 YTL yerine her hasta için daha yüksek meblağlar listeye aktarılmıştır. Dolayısı ile, oluşan Kurum zararını tespit etmek isteyen bir müfettiş, her hasta için talep edilen toplam tetkik bedelini tek tek tespit edecek, daha sonra da Kurumumuzca her hasta için bir adet 908.820 kodlu işlem bedeli ödendiğini dikkate alarak 19,58

YTL'yi bu meblağdan düşecektir. Örneğin Nejla ŞAHİN isimli hasta için oluşan Kurum zararı 7 tetkik için KDV hariç 137,06 YTL değil, 137,06-19,58=117,48 YTL'dir. Bu örneğin binlerce satırdan oluşan bir liste üzerinde yapılması halinde, bilgiyi talep eden müfettişin gönderilen listeyi Kurum zararını belirtecek şekilde ayıklaması için oldukça uzun bir mesai harcaması kaçınılmazdır.

Bu durumdan kaçınabilmek için, gönderilen bilgilerin yeniden süzülmesini gerektirmeyecek ve ilgili bilgi işlem birimi ile karşılıklı teyit edilmiş bir formatın ilgili müfettiş tarafından hazırlanması ve bu şekilde talep edilmesi faydalı olacaktır.

Örnek: "01.09.2007-31.12.2007 tarihleri arasında", "B Hastanesinde", **"4 günden az aralıkla",** "530.590 kodlu" "Arter Kateterizasyonu işlemine alınan", "ödemesi tamamlanmış" ve "kesinti miktarı "0" olan" hastaların listesinin bilgi işlem sisteminden süzülerek gönderilmesi şeklinde bir talep yapılması halinde, gerektiğinde kontrol ederek listede kolaylıkla düzeltme yapılabilmesi için "Önceki İşlem Tarihi", "Sonraki İşlem Tarihi" ve "İşlem Aralığı" şeklinde üç sütun başlığının listede yer alması sağlanmalıdır. Excel formatında istenecek bu listede C sütunu A ve B sütunları arasındaki farkı yansıtacak şekilde formüle edildiğinden hem bir çapraz kontrol sağlanacak hem de 4 gün ve üzeri veri içeren kayıtlar kolaylıkla süzülerek elenip zarar miktarı tespit edilebilecektir.

Hastane Adı	Hasta TCK No.	Takip Tarihi	Takip No.	**Önceki İşlem Tarihi (A)**	**Sonraki İşlem Tarihi (B)**	**İşlem Aralığı (C)**	Hasta Adı ve Soyadı	İşlem Kodu	İşlem Tutarı	Kesinti Tutarı
B	12345678	10.11.2007	2ACD28	11.11.2008	12.11.2008	1 gün	Ali KAYA	530.590	53,40	0

- Bilgi işlem verileri analiz edilirken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, gönderilen listelerden hareketle zarar tespiti esnasında yapılan toplama hatalarıdır. Kurum zararının tespiti amacı ile, çoğunlukla parasal veriler içeren sütunlar Excel programının toplama işlevi kullanılarak alt alta toplanmaktadır. Ancak bilgi işlem sisteminden süzülen veriler Excel programında yer alan kutucuklara aktarılırken

bazı sayısal karakterlerin "sayı", "genel" ya da "para birimi" şeklinde değil de "metin" olarak aktarılması mümkündür. Nadiren de olsa bazı durumlarda Excel programı bu karakterleri toplama işlemine dâhil etmemekte, dolayısı ile olması gerekenden eksik toplamlar alınabilmekte ve Kurumumuz tarafından tahsile edilmesi istenilecek meblağ, olması gerekenden daha düşük olarak tespit edilebilmektedir. Bu durumun yol açacağı toplama hataları aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

Hücrede Yer Alan Sayısal Karakter	**Karakterin Tanımlanma Biçimi**	**Hücrede Yer Alan Sayısal Karakter**	**Karakterin Tanımlanma Biçimi**
2	***Metin***	2	Genel
2	***Metin***	2,00	Sayı
3	Sayı	3,00 YTL	Para Birimi
3	Sayı	3	Sayı
3	Sayı	3	Sayı
TOPLAM	**9**	**TOPLAM**	**13**

Bu tip hatalardan kaçınabilmenin en basit yolu, toplamı alınacak sütunun tamamı "mouse" ya da tuşlar aracılığı ile seçildikten sonra "Veri" menüsünden "Metni Sütunlara Dönüştür" seçeneğinin seçilmesidir. Ekrana gelecek yönlendirme kutusunda hiçbir işaretleme yapmaksızın "İleri" ve "Son" butonlarına basıldığında tüm hücrelerde yer alan veriler ayrım yapılmaksızın toplama işlemine alınmaya hazır hale gelecektir. Bundan sonra toplanacak sütunun tamamı en alttaki boş satır da dâhil olacak şekilde "mouse" ya da tuşlar aracılığı ile işaretlenmeli ve standart araç çubuğunda yer alan **"Σ"** işareti kullanılarak toplam alınmalıdır.

3.10. Denetim Esnasında Yararlanılabilecek Çapraz Sorgulamalar

Kurumumuzca satın alınan sağlık hizmetlerinin parasal boyutu ve işlem hacmi yönünden yıldan yıla artış göstermesi nedeni ile hastanelerin bilgi işlem ortamında süratli ve etkili şekilde denetiminin sağlanması için bilgi işlem sistemlerine büyük yatırımlar yapılmaktadır. Örneğin Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer

alan birçok sınırlamanın MEDULA sistemine entegre edilerek hata ve suiistimallerin anında tespit ve engellenmesi amaçlanmakta, sistem geliştirildikçe insan kaynaklı hata ve suiistimallerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, hiçbir sistem kusursuz olmayıp sistemin geliştirilmesinde özellikle müfettişlerin tecrübe, bilgi ve becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu husus göz ardı edildiğinde, sistemin aksayan yönlerinin bilinmesi ve sistem açıklarından kaynaklanan Kurum zararının tüm boyutları ile ortaya konulması zorlaşmaktadır. Müfettişlerin bu alandaki tecrübe, bilgi ve becerilerinin ortaya konulması açısından ise özellikle denetim esnasında yapılacak çapraz sorgulamalar büyük önem taşımaktadır. Ancak çapraz sorgulamalara geçmeden önce bazı hususların bilinmesinde yarar vardır.

- Çapraz sorgulamalarla ilgili olarak öncelikle bilinmesi gereken ilk husus, MEDULA sisteminin bilgi işlem veri tabanından çekilen bilgilerin, örneğin belli amaçlarla talep edilerek alınan listelerin kesin olmadığıdır. Nitekim aynı listenin denetim yapılan hastaneden de alınması halinde, her iki listede de bazı eksikliklerle karşılaşılabilmektedir.

Örneğin; … Hastanesi'nde yapılan bir denetimde, Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan alınan "909.200 kod numaralı Western Blot testini" yaptıran hasta listesinde olmayan bazı hasta isimlerinin hastaneden alınan listede, hastaneden alınan listede olmayan bazı hasta isimlerinin de Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan alınan listede bulunduğu tespit edilmiştir.

- Bazı durumlarda ise, herhangi bir hastanın tek takip numarası altındaki tedavisine ait günlük detay bilgilerini gösteren listelerde hatalarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle faturaya ait evrak bilgilerinden hareketle, hastanenin ilgili hastaya uyguladığı tedaviye ait ücreti alıp almadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Örneğin; … Hastanesi'nde yapılan bir denetimde, bir hastanın takibi ile ilgili fatura dökümünün MEDULA sisteminde yer aldığı

halde, ilgili hastanenin MEDULA sistemine girdiği ve parasını aldığı faturaların içinde bulunmadığı, oysa takip numarasının alındığı tarihlerdeki fatura mutabakatının da yapıldığı anlaşılmıştır.

- Kimi zaman ilgili hastanelerin programdaki veya yazılımdaki bir hata nedeniyle özellikle ilacın ambalaj hacimlerini ya da kodlarını adet olarak girdiği ve yapılan işlemleri yüksek adette faturaladığı görülebilmektedir.

Örneğin, … Hastanesi'nde yapılan denetimde 3516 sıra numarasında kayıtlı pelvis grafisi işlemi yapılıp adet hanesine "1" rakamı girilmesi gerekirken "3516" adet yazıldığı ve 3516 defa yapılmış gibi faturalandığı tespit edilmiştir.

Örneğin, … Hastanesi'nde yapılan denetimde, beslenme solüsyonu uygulanan hastalarda 1500 cc'lik bir adet veya 2000 cc'lik bir adet tahakkuk yapılması yerine şişe hacimleri toplamının adet olarak MEDULA'ya girildiği ve yüksek tutardaki bedelin Kurumumuza faturalandığı tespit edilmiştir.

Örneğin, … Hastanesi'nde yapılan denetimde 609.140 kodlu intraoperatif kolanjiyografi işleminin kod bilgisi adet olarak girildiğinden 609140 adet işlem yapılmış gibi faturalandığı tespit edilmiştir.

- Dolayısı ile çapraz sorgulamalara girişilirken elde edilen sonuçların sıhhatlerinin de sorgulanması unutulmamalı, elde edilen veriler olabildiğince hatada arındırılmalıdır.

Denetimlerde faydalanabilecek bazı çapraz sorgu yöntemleri aşağıda sayılmış olup, bu örneklerin her müfettişin bilgi ve deneyimi ile geliştirilmesi mümkündür.

3.10.1. Vefat Tarihinden Sonraki Tarihlerde Tıbbi İşlem Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması

Hastanede bir veya iki yıl içinde vefat edenlerin listesi alınıp,

hastaların vefat tarihlerinden sonraki günlerde sağlık hizmeti aldığına dair fatura düzenlenip düzenlenmediği araştırılmalıdır. Ayrıca aylık veya gelir almakta iken vefat edenlerin aylık veya gelirlerinin de kesilip kesilmediği kontrol edilebilir.

3.10.2. 2007 SUT' a Göre EK-5/A ve EK-5/C Listelerinde Yer Alan Malzemelerin Fiyatlandırılması

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nin 20.2.1. numaralı maddesine göre, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen, Tebliğ ve ekindeki EK-5/A ve EK-5/C listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin bedelleri bu listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden "fatura tutarını aşmamak şartıyla" ödeneceği halde, bazen fatura tutarı daha düşük olan malzemelerin bile EK-5/A ve EK-5/C listelerindeki fiyatlardan fatura edildiği anlaşılmıştır.

3.10.3. Hazine Kesintisinin Hatalı Alınması

Yapılan bazı denetimlerde, ülke çapında resmi sağlık kuruluşu sayılan bazı üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre Tebliğ ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerden Hazine kesintisinin 01.01.2008 tarihinden itibaren % 1 oranında alınması gerekirken % 5 oranında haksız yere alınması suretiyle Kurumumuzun zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. % 5 oranını doğru uyguladığını bildiren hastanelerin de bu oranı 4. veya 5. aylarda uygulamaya başladıkları halde geriye dönük bir düzeltme yapmadıkları tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin de Hazine kesintisini 01.01.2007 tarihinden itibaren % 1 oranında uygulamaları gerekirken bazı hastanelerin bazen % 5, bazen de % 15 uygulayabildikleri anlaşılmıştır.

3.10.4. SHÇEK Kesintisinin Hatalı Alınması

Resmi sağlık kurum ve kuruluşu sayılan üniversite hastanelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre Tebliğ ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin satış

fiyatı üzerinden % 8 KDV, % 15 İşletme gideri ve % 1 Hazine kesintisi dışında, ayrıca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 18/k maddesi hükmüne aykırı olarak % 1 oranında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bazı Devlet hastanelerinin de SHÇEK kesintisini % 1 oranında yapmaları gerekirken % 2 oranında yaptıkları öğrenilmiştir.

3.10.5. Bazı Testler Negatif Olduğu Halde Doğrulama Testlerinin Fatura Edilmesi

- 909.200 kod numaralı "Western Blot" doğrulama testinin Anti-HCV veya Anti HIV testleri negatif olduğunda çalışılmaması gerekirken Kurumumuza fatura edildiği,

- Yine 908.160 kod numaralı "HCV Genotiplendirme" testinin HCV virüs yükü negatif olduğunda çalışılmaması gerekirken Kurumumuza fatura edildiği,

- 907.220 kod numaralı "CMV IgG avidite" testinin CMV – IgG negatif olduğunda çalışılmaması gerekirken Kurumumuza fatura edildiği,

- 908.220 kod numaralı "HIV RNA" testinin Anti-HIV sonucu negatif olduğunda çalışılmaması gerekirken Kurumumuza fatura edildiği,

- 908.170 kod numaralı "HCV RNA" testinin Anti-HCV sonucu negatif olduğunda çalışılmaması ve fatura edilmemesi gerekirken Kurumumuza fatura edildiği,

- Bu testlerin bazen çalışılmadığı halde de Kurumumuza fatura edildiği tespit edilmiştir.

3.10.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

Bazen hastaların fizik tedavisi için işlemleri tamamladıklarında fizik tedavi yapılmış gibi peşin fatura giriş işlemlerinin yapıldığı,

ancak tedaviye başlanması için süre verilen hasta başka bir merkeze gittiğinde ilk işlemlerinin iptal edilmediği,

Yine, fizik tedavisi yapılan hastaların günlük tedavilerinin FTR Tedavi Formu'nda takip edildiği, özellikle Terapist Kayıtları bölümünde tedaviye gelip gelmediklerinin işaretlendiği, hasta eksik tedavi yaptırsa ya da bir gün gelip bir daha hiç gelmese de tam gelmiş gibi fatura edildiği, fatura ile FTR Tedavi Formları karşılaştırıldığında yapılmadığı halde MEDULA sistemine fatura edilen FTR'lerin tespit edilebildiği anlaşılmıştır.

Örneğin; … Hastanesi'nde yapılan denetimde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşında ve 18.09.2007-18.10.2007 tarihleri arasındaki fizik tedavisi Kurumumuza fatura edilen hastanın FTR Tedavi Formu'nda 3 gün tedavi gördüğünün işaretli olduğu, ancak aynı hastanın başka bir ildeki Fizik Tedavi Dal Merkezi'nde 24.09.2007-15.10.2007 tarihleri arasındaki 18 gün fizik tedavisinin Kurumumuza fatura edildiği tespit edilmiş, hasta ile yapılan görüşmede de iki farklı ilde tedavisine devam ettiği teyit edilmiştir.

Başka bir denetimde ise, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulaması yapan personelle yapılan görüşmelerde günde 30 veya 45 dakika arasında bir defa uygulandığı, çok aşırı bir durum olursa çok nadir olarak iki defa uygulandığı öğrenilen 702.170 kod numaralı "eklem hareket açıklığı" egzersizinin, 702.230 kod numaralı "germe" egzersizinin, 702.240 kod numaralı "gevşeme" egzersizinin, 702.320 kod numaralı "mobilizasyon/manipulasyon" uygulamasının bazen aynı gün 10 kez civarında faturalanabildiği,

Yine, aynı görüşmelerde ya hastaya ya da hasta çocuk ise yakınlarına öğretildiği ve hareketleri resimli olarak gösteren matbu bir broşür verildiği öğrenilen 702.210 kod numaralı "ev programı/aile eğitimi" işleminin de bir defa faturalanması gerekirken her gün, hatta bazı günler birden fazla faturalanabildiği tespit edilmiştir.

3.10.7. MEDULA Sistemindeki Bazı İşlemlerdeki Kısıtlama Aksaklıkları

MEDULA sisteminde belirtilen bazı işlemlerin isminden günlük faturalandırılmaları gerektiği anlaşıldığı halde kısıtlama olmadığı gerekçesi ile birden fazla faturalandırabildikleri, bazı kısıtlamaların ise sistemde tanımlı olmadığı tespit edilmiştir.

3.10.7.1. Bir Hastada Sadece Bir Kez Faturalanabilecek İşlemler

Bir hastada sadece bir kez faturalandırılması gereken işlemlerin bazen aynı gün birden fazla yazıldığı görülmüştür. Bunlardan bazıları;

- 702.210 Ev programı/aile eğitimi,
- 530.090 Diyabetli hasta eğitimi
- 610.820 ESWT,
- 703.590 Cam terapi, toplam tedavi,
- 704.090 LarenJektomilinin konuşma tedavisi,
- 911.190 Hazır boyalı preparat ve/veya parafinblok işlemleridir.

3.10.7.2. Günde Bir Kez Faturalanabilecek İşlemler

Hastada günde sadece bir kez faturalanabilecek işlemlerin günde birden fazla faturalanabildiği görülmüştür. Bunlardan bazıları;

- 530.680 Kateter pansumanı ve bakımı,
- 530.160 İntravenöz ilaç infüzyonu,

- 530.350 Nebülazatör ile ilaç uygulaması,
- 530.625 İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü,
- 530.330 Monitorizasyon günlük,
- 530.170 Kan gazları takibi,
- 530.340 Nazogastrik sonda uygulaması,
- 550.040 Endotrokeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi,
- 617.220 Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon,
- 801.542 Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu,
- 530.410 Sütur alınması,
- 530.950 Vücut temizliği, yenidoğan,
- 530.890 Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan
- 530.920 Surfakten tedavi uygulaması, yenidoğan,
- 530.960 Yenidoğan monitorizasyonu,
- 530.970 Yenidoğan TA ölçümü,
- 701.660 Günlük yaşam aktiviteleri testi,
- 703.050 EEG monitorizasyon,
- 704.260 Periton dializi takibi,
- 704.541 Sürekli fetal monitorizasyon,
- 704.660 Çoklu infüzyon kemoterapi,

- 704.690 İnfüzyon kemoterapisi,
- 704.780 Steril ünitede bakım hizmeti,
- 530.490 Ventilatör ile takip,
- 530.700 (Günlük) Nazal CPAP uygulaması,
- 550.050 Hasta kontrolluanaljezi, epidura/intravenöz vb,
- 551.280 Gastrik intramukozal pH, tonometri,
- 605.950 Kardiopulmoner yetmezliği nedeni ile uzamış ekstra karpereal dolaşım,
- 608.890 Tüp ve kateter torakostomi, günlük izlem,
- 530.440 Transkutanöz pCO2 ölçümü,
- 530.450 Transkutanöz pC2 ölçümü,
- 700.470 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat),
- 700.510 Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat),
- 700.540 24 saat EKG kaydı (Holter),
- 701.250 24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması işlemleridir.

3.10.8. Kız Çocuklarının Analık Yardımlarından Faydalandırılmaları

506 sayılı Kanun'un 43. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 15. maddelerine göre Kurumumuzdan kız çocuğu olarak aylık alanlarla kız çocuğu olarak hastalık yardımlarından faydalandırılanların analık yardımlarından faydalanamaması gerekirken çeşitli tarihlerde doğum bölümünde muayene ve tedavi oldukları, yine doğumla

ilgili veya çocuklarının ilaçlarını kendi sağlık karneleri üzerinden alabildikleri anlaşılmıştır.

Örneğin, … Hastanesi'nde yapılan denetimde bazı sigortalı kız çocukları ile hak sahibi olarak aylık alan kız çocuklarının doğum yapmaları nedeni ile analık yardımlarından yararlandıkları tespit edilmiştir.

3.11. Denetim Esnasında Soruşturma Gerektiren Hususların Tespiti Halinde Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere, müfettişlerce yürütülecek soruşturma usulleri ile ilgili esaslar gerek SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin muhtelif maddelerinde, gerekse Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Teftiş ve Denetim Rehberi'nin 1.3 ve 2.5 numaralı bölümlerinde açıklanmış olup bu konuda getirilen düzenlemelere tüm müfettişlerce uyulması mecburidir.

Adı geçen yönetmeliğin 7. maddesinin (ç) bendine göre; "sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak",

Aynı maddenin (g) bendine göre ise "sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak",

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın görevleri arasında sayılmaktadır.

Yine aynı yönetmeliğin 68. maddesinde, "soruşturmaların yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı ilgililer hakkında yapılacağı";

79. maddesinde ise, "müfettişlerin;

a) Hüviyeti belli kimseler tarafından kişi veya olayın belirtildiği, soyut ve genel nitelikte olmayan, açık adresli, imzalı ve suç teşkil edecek nitelikte iddiaları içeren, ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmayan ihbar veya şikâyet dilekçelerinde belirtilen konularda,

b) Teftiş ve inceleme sırasında suç sayılan bir eylemi saptamaları halinde,

c) Başkan tarafından doğrudan emir verilmesi halinde,

soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlü oldukları",

"Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durumun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilmesi gerektiği, ancak geciktirilmesinde sakınca görülen veya anında el konulması gereken durumlarda, suç delillerinin saptanması amacıyla, doğrudan doğruya soruşturmaya başlanacağı, gerekli önlemlerin alınacağı ve durumun en seri vasıta ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirileceği",

81. maddesinde; "soruşturma raporlarının, doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi konusunda ilgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmesi asıl olmakla birlikte, "soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi, adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirileceği", "suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev'i ile kanunların hangi maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporunun iki örnek

olarak düzenlenerek aslının ilgili Cumhuriyet Savcılığına, örneğinin ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na gönderileceği",

hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen ve detayları hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Teftiş ve Denetim Rehberi'nin 1.3 ve 2.5 numaralı bölümlerinde de bilgi verilen soruşturma usullerine tüm müfettişlerce uyulması mecburidir.

Öte yandan, bilhassa denetimlerin mahallinde yapıldığı durumlarda, soruşturma açılmasını gerektiren herhangi bir suiistimal tespit edildiği takdirde durumun ilgili müfettiş tarafından;

- Gecikmesinde sakınca görülen ya da anında el konulması gereken bir durum bulunup bulunmadığı,

- Beklenilmesi halinde Kurum zararının artma ihtimali bulunup bulunmadığı,

- Doğrudan Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi gerekli özel bir durum bulunup bulunmadığı,

- İlgililerin kaçması, delil mahiyetindeki evrakın yok edilmesi, zamanaşımına uğrama ihtimali bulunup bulunmadığı,

yönlerinden değerlendirilerek, herhangi bir sakınca olmadığı takdirde soruşturma taleplerinin denetim sonuna bırakılması, denetim bitene kadar haklarında soruşturma yapılması düşünülen gerçek ve tüzel kişilere bu durumun belli edilmemesi, ayrıca soruşturma esnasında yararlanılabileceği düşünülen evrakın muhafaza altına alınmasında fayda bulunmaktadır.

3.12. Denetimlerde Uyulacak Diğer Usul ve Esaslar:

Hastane denetimlerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nde tanımlanan inceleme ve soruşturma işlemleri

çerçevesinde yürütülmesi esnasında uyulması gereken diğer hususlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Teftiş ve Denetim Rehberi'nin 1.2 ve 1.3 numaralı bölümlerinde açıklanmış olup bu hususlara uyulması gerekmektedir.

BÖLÜM 4

RAPORLAMA

4.1. Raporlamaya Hazırlık Aşaması

Bilindiği üzere, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 71. maddesi uyarınca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda görevli tüm müfettişler çalışmalarının sonucunda ve yürüttükleri işin özelliğine göre;

a) Cevaplı Teftiş Raporu,

b) Genel Durum Raporu,

c) İnceleme Raporu,

ç) Personel Performans Değerlendirme Raporu,

d) Soruşturma Raporu,

e) Ön İnceleme Raporu,

f) Asgari İşçilik İnceleme Raporu,

olmak üzere toplam yedi çeşit rapor düzenlemektedirler. Daha önce de değinildiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 17. maddesinin (f) bendinde SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın "sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler" hakkındaki yetkisinin "inceleme ve soruşturma yapmaktan" ibaret olduğu belirtildiğinden, Kurumumuzca sağlık hizmeti satın alınan tüm hastanelerle ilgili denetimler sonucunda düzenlenecek raporların da ya inceleme ya da soruşturma raporu olması gerekmektedir.

Müfettişlerce tamamlanan her iş sonucunda düzenlenerek ilgili makam ya da birimlerin onay, bilgi ve değerlendirmelerine sunulan bu raporların;

- İlgili onay mercilerinin onayından geçtikten sonra kimi zaman Kurumumuz adına yürütülecek işlemler için talimat niteliğini aldıkları,

- Kurumumuzun yanında Cumhuriyet Savcılıkları, Bakanlıklar, Valilikler ve çeşitli meslek kuruluşları gibi çok farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek farklı mahiyetteki işlemlerin dayanağını oluşturdukları, duruşmalarda delil olarak kabul edilebildikleri,

- Raporu tamamlayan müfettiş görevden ayrılmış olsa bile her zaman dava ya da şikâyet konusu edilebildikleri,

- Tanziminden sonra ilgili birimlerce sıklıkla mütalaa talebini gerektirebildiği,

göz önüne alınarak, "tamamlanan işle ilgili denetim gerekçesi", "denetim konusunun nasıl öğrenildiği", "denetimin başlama ve bitiş tarihi", "denetim kapsamında görüşülen kişiler, yapılan inceleme ve araştırmalar", "tetkik edilen bilgi ve belgeler", "denetim sonucunda yapılan tespitler, erişilen deliller ve ulaşılan kanaatler" ile "bu kanaatlere varılma gerekçesi gibi" yapılan denetimle her türlü bilgiyi içermelerine dikkat edilmelidir.

Yapılan hastane denetimleri sonucunda düzenlenecek raporların yukarıda belirtilen ihtiyaçlara cevap vermesi ve denetim gerekçesinde aydınlatılması istenilen tüm hususlarda gerekli ve yeterli bilgileri içerebilmesi, raporun yazımı öncesinde iyi bir hazırlık aşaması geçirilmesine bağlıdır. Bunun için, rapor yazımından önce uygun görülecek bir süre ile hazırlık çalışmalarına zaman ayrılması, bu aşamanın kesinlikle zaman kaybı gibi görülmemesi ve özenli şekilde yürütülmesi gereklidir.

Tamamlanan işlerin rapora bağlanma süresini gereksiz yere uzatmayacak kadar süratli ve kaliteli bir hazırlık aşamasının yürütülmesi esnasında dikkat edilecek hususlar şu şekilde sıralanabilir:

- Öncelikle, rapora hazırlık aşamasının iş bitiminde değil iş esnasında başladığı bilinmelidir. Bu nedenle, denetimin ön hazırlık ve strateji belirleme aşamasında alınan kararlar doğrultusunda hangi hususların inceleme konusu edilerek hangi yönlerden araştırılacağı netleştirilmeli, değişiklik gerektiren durumlarda bile denetimle ilgili bütüncül yaklaşım kaybedilmemelidir.

- Bununla bağlantılı olarak, denetim esnasında raporda belirtilmesi gerekli görülen her tespit; tekrar inceleme, araştırma ya da ifade almayı gerektirmeyecek şekilde detaylı olarak not alınmalı, tespite dayanak oluşturacak mahiyetteki bilgi ve belgeler derlenerek düzgün şekilde dosyalanmalıdır. Bu hususa riayet edilmesi, bilhassa uzun süren ve kapsamı geniş olan denetimlerde önem taşımaktadır. Çoğunlukla yapılan hata, bilhassa genel amaçlı hastane denetimleri esnasında bulunan suiistimal örneklerini akılda tutmakla yetinerek örnek mahiyetteki belgelerin zamanında fotokopi edilmemesi ve dosyalanmaması, hangi dosya içinde rastlanılmışsa bir kulakçık takarak köşeye atılmasıdır. Bu yöntemde, denetim bitene kadar arasında kulakçıklarla duran dosyalar rapor yazım aşamasında tekrar ele alınarak hangi kulakçığın hangi suiistimal örneği ile ilgili belgeye ait olduğu araştırılmakta, böylece gereksiz yere zaman kaybedilmektedir.

Bu gibi durumlardan kaçınmak için; denetime hazırlık aşamasında bir makineli klasör temin edilerek içerisine birkaç adet şeffaf kapaklı dosya yerleştirilmesi, araştırılacak konu başlıklarının ya da riskli denetim alanlarının bu dosyaların etiketlerine yazılması, ilgili konuların araştırılması esnasında bulunan her suiistimal örneği ile ilgili belgelerin -belgenin hangi yönden suiistimale örnek teşkil ettiğini açıklayıcı kısa notlarla birlikte- bu dosyaların

içerisine yerleştirilmesi, hatta mümkün ise doğrudan rapor metnine aktarılması tavsiye edilebilir.

- Hazırlık aşamasında yapılan bir diğer hata ise, suiistimal konusunu genel tabirlerle not alarak, gerektiğinde ilgili belgeye ulaşım imkânının kaybedilmesidir. Bu nedenle, yapılan her tespit ile ilgili olarak not alınırken "raporu okuyan herhangi bir merciinin gerektiğinde belgeye yeniden erişmesini sağlayacak bilgilerin belirtilmesi (hastanın adı, TC kimlik numarası, makbuzun tarihi, hasta dosya numarası, MEDULA takip numarası, vb.), suiistimalin ne olduğunun ve hangi mevzuat maddesine aykırı olduğunun belirtilmesi, suiistimal tespiti bir mevzuat maddesine değil de genel nitelikli bir bilgiye dayanıyorsa (basiretli bir tüccar gibi davranmamak, kamunun zararına iş ve işlem yapmak, vb.) bu kanaate nereden varıldığının izah edilmesi gerekir. Aşağıda bu durumla ilgili bazı denetim notu örnekleri yer almaktadır.

Örnek 1**:** SUT Ek-8 listesindeki "705.370" kodlu "Eritrosit Suspansiyonu" işlem açıklamasına göre, bu işlemin bir hastanın aynı takip numarası altında takip edilen tedavisi esnasında yapılan "705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670, 906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600, 907.610, 705.240, 705.280" kodlu kan tetkikleri ile birlikte fatura edilmemesi gerekirken, A Hastanesi tarafından düzenlenen pek çok faturada, yukarıda belirtilen kodlu işlemlerin 705.370" kodlu "Eritrosit Suspansiyonu" işlemi ile birlikte faturalandığı görülmüştür.

Bu izahattan sonra aşağıdaki şekilde tek tek örnek verilebileceği gibi, aynı bilgileri içeren bir listenin de rapor eklerine alınması mümkündür.

Örnek Not: 37AC2B takip numaralı ve Adnan SOYKAN isimli hasta için, 59,40 YTL bedelli "905.090 Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini" işleminin iki defa yapılarak "705.370 Eritrosit Suspansiyonu" işlemi ile birlikte faturalandığı ve kesinti

yapılmayan bu işlemden dolayı KDV hariç toplam 118,80 YTL Kurum zararına yol açıldığı anlaşılmıştır.

Örnek Tablo:

"705.370" kodlu "Eritrosit Suspansiyonu" İşlemi İle Beraber Yapılan Hatalı Faturalama Listesi

Sıra No.	Takip No	Hasta Adı Soyadı	Hatalı Faturalanan İşlem Kodu	Hatalı Faturalanan İşlem Adı	Hatalı Faturalanan İşlem Adedi	Hatalı Faturalanan İşlem Bedeli (KDV Hariç)	Yapılan Kurum Kesintisi	Oluşan Net Kurum Zararı (KDV Hariç)

Örnek 2: Müfettişliğimizce yapılan denetimler esnasında, A Hastanesi tarafından 37AC2B, 45G32G, 3QX345 takip numaraları altında tedavi edilen ve tedavi bedelleri Kurumumuzdan tahsil edilen Ali KOÇ, Vehbi YILMAZ ve Servet YILDIRIM isimli hastaların 116328, 43208 ve 223594 numaralı hasta dosyalarına ulaşılamadığı, zira bu dosyaların adı geçen hastalar tarafından arşivden alınarak tedavi esnasında ilgili doktora götürüldüğü, ancak tedavi bitiminde arşive bırakılmadıkları anlaşılmıştır. A Hastanesi ile imzalanan tip sözleşmenin 3.1.7.1 numaralı maddesine göre gerektiği takdirde Kurumumuzca istenip tetkik edilebilecek evraktan olan hasta dosyalarının hastalara verilmeyip ilgili hastanede saklanması hususunda ilgili hastanenin yazılı olarak uyarılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

- Yine, hazırlık aşamalarında sıklıkla yapılan bir hata da, raporda kullanılacak listelerin zamanında hazırlanmayıp rapor yazım aşamasına bırakılmasıdır. Bu nedenle oluşacak zaman kayıplarını en aza indirmek için rapor ekine alınacak listelerin denetim esnasında başlık, sütun, sayfa düzeni vb. yönlerden tam anlamı ile hazırlanması, gerekli ise tazim edenlerce imzalanması ve dosyalanması gerekmektedir.

- Raporlamaya hazırlık aşamasında yapılması gerekli bir diğer eylem, rapora konu edilecek tespitlerin hangi sırada ve nasıl ele alınacağı, nasıl ifade edileceği hakkında karar vererek bir rapor planı hazırlamaktır. Bu esnada raporlarda bulunması gerekli başlıkların yanında, "Konunun Değerlendirilmesi" başlığı altında konunun kaç alt bölümde ele alınarak izah edileceği belirlenmelidir. Bu aşamanın herhangi bir kitabın "İçindekiler" bölümünün yazılmasına benzetilmesi de mümkündür.

- Raporun başlıkları, diğer bir deyişle "İçindekiler" listesi belirlendikten sonra, her başlık altında ele alınan konunun ne şekilde izah edileceğinin, olayların tarih sırasına göre mi, kişiler ya da eylemler yönünden mi yoksa başka şekilde mi ele alınacağının, hangi yöntemin ne kadar vakit alacağının, her konunun aynı yöntemle izah edilerek değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığının, hangi yöntemin zaman maliyetinin ne olduğunun zihnen planlanması ve müfettişin zihninde bir taslak metin oluşturulması gerekmektedir. Bu aşamanın da yazarların "ilham" evresi şeklinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu safhada özellikle, raporun hangi sorunları ortaya koymak ya da hangi tespitleri izah etmek için yazıldığı, tahminen hangi birim ya da makamlara gönderileceği, bu makamların taleplerini karşılayacak bilgilerin neler olduğu ve bu bilgilerin rapor planında yer alıp almadığına özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesi önerilen bir raporda tespit edilen suçun ne olduğunun açıklanmaması ya da faillerin net bir şekilde belirtilmemesi, ilave yazışmalara ya da rapor iadesine yol açabilecektir.

Plan ve tasarım yapıldıktan, gerekli belgeler de düzgün şekilde tasniflenerek rapor yazımına hazır hale getirildikten sonra raporu yazmak oldukça kolaylaşacaktır.

4.2. Raporlarda Bulunması Gerekli Hususlar

4.2.1. İnceleme Raporları

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 74. maddesinin birinci fıkrasının (a, b, ç) fıkraları uyarınca düzenlenecek inceleme raporları "Giriş", "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar", "Alınan İfadeler", "Konunun Değerlendirilmesi" ile "Sonuç ve Kanaat" bölümlerinden oluşur.

a) Giriş:

İncelemenin konusu, inceleme konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği, incelemeye nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

b) Yapılan İnceleme ve Araştırmalar:

İncelemenin konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) Alınan İfadeler:

İnceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilir, böylece alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır. İfadesi alınan kişilerin tamamına yer verilmesi asıldır, ancak ifadesi alınanların çok fazla olması durumunda, dizi pusulasındaki ek numaralarına atıfta bulunulmakla yetinilebilir.

d) Konunun Değerlendirilmesi:

İncelemenin yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da

fiiller, fiilin fail tarafından ne şekilde, nasıl ve ne zaman uygulandığı anlatılıp açıklanır.

Tanıkların ve faillerin ifadelerine değinilir. Failin fiilini açıkça kabul etmesi durumunda bu husus belirtilir ve sonuç bir hükme bağlanır. Örtülü (zımni) kabul veya reddetme durumlarında ifadeler; incelemede elde edilen delil, karine ve emarelerle karşılaştırılarak tahlil edilir. Fiilin sübut şekli gösterilerek, bir sonuca ve hükme ulaşılır.

Delilerin anlatım sıralaması, önce kesin deliller (kayıt ve belgeler), daha sonra takdiri deliller (tanık ifadeleri, bilirkişi görüşleri, vb.) şeklinde yapılır.

e) Sonuç ve Kanaat Bölümü:

"Kim", "ne", "nerede", "ne zaman", "nasıl" ve "niçin" sorularına yanıt oluşturacak şekilde; konu, tespit ve değerlendirmeler (Konunun Değerlendirilmesi bölümü) kısaca özetlenir. Daha sonra, konuya ilişkin görüş ve önerilere yer verilir. Görüş ve öneriler; "Mali Yönden" ve "İdari Yönden" başlıkları altında; kapsam ve niteliklerine göre bu başlıklardan gerektiği kadarı kullanılmak suretiyle tasnif edilir.

Sonuç ve Kanaat Bölümü başlığı altında yer alacak özetin yazımı esnasında, konunun nasıl ele alınarak değerlendirildiği ve hangi tespitlerin yapıldığı hususundaki açıklamaların, inceleme konusu ile varılan kanaat arasındaki mantıki bağlantıyı kurmasına özellikle dikkat edilmeli, bağlantı kurulması amacına hizmet etmeyecek nitelikteki bilgilere (yazışma yapılan tüm kurumların ismen tek tek sayılması, ifadesi alınan kişilerin isimlerinin tek tek verilmesi vb.) yer verilmemeli, raporun genel mahiyetine ters kanaatlere yol açacak açıklamalardan kaçınılmalıdır.

Özellikle "Mali Yönden" başlığı altında açıklamalar yapılırken, oluşan Kurum zararının nasıl, ne şekilde, hangi kişi ve/veya kuruluşlardan tahsil edileceği belirtilmelidir. Bu başlık altında

tespit edilen zarar miktarı belirtilirken zararın KDV dâhil mi hariç mi hesaplandığı da özellikle belirtilmeli, faizi ile birlikte tahsili önerilen meblağların faiz hesabı başlangıç tarihlerinin belirlenmesi için zararın oluştuğu tarihler açıkça yazılmalıdır.

4.2.2. Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Soruşturma raporları; "Giriş", "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar", "Alınan İfade ve Savunmalar" "Konunun Değerlendirilmesi" ile "Sonuç ve Kanaat" bölümlerinden oluşur.

a) Giriş:

Soruşturmanın konusu; soruşturma konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği; soruşturmaya nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

b) Yapılan İnceleme ve Araştırmalar:

Soruşturmanın konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) Alınan İfade ve Savunmalar:

- Soruşturma konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilerek alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır. İfadesi alınan kişilerin tamamına yer verilmesi asıldır; ancak ifadesi alınanların çok fazla olması durumunda, dizi pusulasındaki ek numaralarına atıfta bulunulmakla yetinilebilir.

- Soruşturma konusuyla ilgili olarak savunması alınan kişilerin isimlerine yer verilir.

d) Konunun Değerlendirilmesi:

Soruşturmanın yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da fiiller, fiilin failce ne şekilde, nasıl ve ne zaman uygulandığı anlatılıp açıklanır.

Tanıkların ve faillerin ifadelerine değinilir. Faillerin savunmaları açıklanır ve tahlil edilir. Failin fiilini açıkça kabul etmesi durumunda bu husus belirtilir ve sonuç bir hükme bağlanır. Örtülü (zımni) kabul veya reddetme durumlarında ifade ve savunmalar, soruşturmada elde edilen delil, karine ve emarelerle karşılaştırılarak tahlil edilir. Fiilin sübut şekli gösterilerek, bir sonuca ve hükme ulaşılır.

Delilerin anlatım sıralaması; önce kesin deliller (kayıt ve belgeler), daha sonra takdiri deliller (tanık ifadeleri, bilirkişi görüşleri, vb.) şeklinde yapılır.

e) Sonuç ve Kanaat:

"Kim", "ne", "nerede", "ne zaman", "nasıl" ve "niçin" sorularına yanıt oluşturacak şekilde; konu, tespit ve değerlendirmeler (Konunun Değerlendirilmesi" bölümü) kısaca özetlenir. Daha sonra, konuya ilişkin görüş ve önerilere yer verilir. Görüş ve öneriler; "Türk Ceza Kanunu Yönünden", "Disiplin İşlemleri Yönünden", "Mali Yönden" ve "İdari Yönden" başlıkları altında; kapsam ve niteliklerine göre bu başlıklardan gerektiği kadarı kullanılmak suretiyle tasnif edilir.

Sonuç ve Kanaat Bölümü başlığı altında yer alacak özetin yazımı esnasında, konunun nasıl ele alınarak değerlendirildiği ve hangi tespitlerin yapıldığı hususundaki açıklamaların, inceleme konusu ile varılan kanaat arasındaki mantıki bağlantıyı kurmasına

özellikle dikkat edilmeli, bağlantı kurulması amacına hizmet etmeyecek nitelikteki bilgilere (yazışma yapılan tüm kurumların ismen tek tek sayılması, ifadesi alınan kişilerin isimlerinin tek tek verilmesi vb.) yer verilmemeli, raporun genel mahiyetine ters kanaatlere yol açacak açıklamalardan kaçınılmalıdır.

"Türk Ceza Kanunu Yönünden" başlığı altında; Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ettiği kanaatine varılan işlem ve eylemler ile bunların failleri hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması yönündeki önerilere yer verilir.

"Disiplin İşlemleri Yönünden" başlığı altında; disiplin cezası gerektiren fiil ve haller tanımlanır. Disiplin cezasının türü ve dayandığı kanun hükmü; madde, bent ve fıkra belirtilmek suretiyle belirtilir.

"Mali Yönden" başlığı altında; oluşan Kurum zararının nasıl, ne şekilde, hangi kişi ve/veya kuruluşlardan tahsil edileceği belirtilir. Bu başlık altında tespit edilen zarar miktarı belirtilirken zararın KDV dâhil mi hariç mi hesaplandığı da özellikle belirtilmeli, faizi ile birlikte tahsili önerilen meblağların faiz hesabı başlangıç tarihlerinin belirlenmesi için zararın oluştuğu tarihler açıkça yazılmalıdır.

"İdari Yönden" başlığı altında; Kurum sigortalıları, emeklileri, hak sahipleri ve diğer ilgili kişiler hakkında; Kurum'un sigortalılık, emeklilik, sağlık sigortası ve diğer mevzuatı uyarınca yapılması gerekli iş ve işlemlere, sadece soruşturma konusu ile sınırlı kalmak kaydıyla, alınması gereken önlemlere ve/veya yapılması gereken işlemlere yer verilir.

4.3. Rapor Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar

Raporların yazılmasında genel olarak şu hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

a) Raporlar Türkçe anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Herhangi bir kelimenin doğru yazılıp yazılmadığı,

yerinde kullanılıp kullanılmadığı ya da imlâ kuralları ile ilgili bir tereddüt olduğunda Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü ile Yazım Kılavuzu temel başvuru kaynağı olup aynı bilgilere www.tdk.org.tr ya da www.tdk.gov.tr adreslerinden erişilmesi de mümkündür.

b) Tetkik edilen konuyla ilgili bilgi ve belgeler raporda doğru ve eksiksiz bir şekilde yer almalı, bilgilerin hangi belge ya da bilgilere dayandığı (kanun ve madde numarası, ilgili kurumun adı, vb.) belirtilmelidir.

c) Rapor tamam olmalıdır. Diğer bir deyişle, denetim konusu ile ilgili olarak varılan tüm kanaatleri açıklayacak, akla gelebilecek her soruya cevap verecek şekilde yazılmalı, adli mercilerce de ele alınmış olsa bile, başka bir araştırmaya ihtiyaç göstermeyecek şekilde tamamlanmalıdır.

d) Rapor açık olmalıdır. Diğer bir deyişle, kullanılan cümlelerin ve ifade edilen fikirlerin rahatlıkla anlaşılacak ve tereddüde yer bırakılmayacak şekilde açık ve sade olması, her paragrafın ayrı bir ana fikre ayrılması, cümlelerin etkili bir ifade taşıması, birden fazla anlamı olan kelimelerin doğru anlamlarını ifade edecek şekilde kullanılmaları gerekir. Anlamı kesinlikle bilinmeyen kelimelerin kullanılmasından sakınılmalıdır.

e) Rapor kısa olmalıdır. Diğer bir deyişle, mümkün olduğu kadar kısa cümlelerle yazılmalıdır. Gerek fikir bakımından gerekse kelime ve cümleler itibariyle tekrara yer vermekten kaçınılmalı, bilgisayar teknolojisi sayfa arttırma amacıyla kullanılmamalıdır.

g) Raporların yazımında "Times New Roman" yazı tipi, 12 karakter boyutu ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.

h) İnceleme ve soruşturmalarla ilgili her türlü belge, birden başlayarak müteselsil sıra numarası altında inceleme ve soruşturma raporlarına iliştirilmelidir. Raporların ilişiklerini teşkil eden her türlü evrak mutlak surette müfettişlik resmi mührü ile mühürlenerek paraflanmalıdır.

ı) İnceleme ve soruşturma çalışmaları sonucunda düzenlenecek raporlar, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na (gruplarda görevli müfettişler bağlı oldukları grup başkanlıklarına) teslim edilmelidir.

i) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilmelidir. Yapılan değerlendirme sonucunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca benimsenen görüş çerçevesinde, raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca ilgili müfettişten ya da müfettişlerden yazılı olarak istenir. Grup Başkanlıklarında görevli müfettişlerle ilgili yazışmalar, ilgili grup başkanlığı aracılığıyla yapılır. Müfettiş/müfettişlerin isteğe katılmaması halinde, rapor; farklı görüşlerle birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanı'nın görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak Kurum Başkanı'na sunulur ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

j) Düzenlenecek raporlarda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunu gerektiren bir tespit bulunduğu takdirde mahkemeyi ikna edebilecek mahiyetteki deliller, suçun tanımı, niteliği, faili, temas ettiği TCK maddeleri açıkça belirtilmeli, suçun ispatı için gerekli olan deliller rapora eklenmelidir.

k) Soruşturma ile ilgili ve suç delilleri mahiyetinde bulunan müsbit evrakın Müfettişin takdirine göre asılları veya birer suretleri rapora iliştirilmelidir.

l) Soruşturma raporlarının, doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi konusunda ilgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na gönderilmesi asıldır. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi, adli

kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilmelidir. Suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev'i ile Kanunların hangi maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporunun, iki örnek olarak düzenlenerek aslının ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na, örneğinin ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na gönderilmesi gereklidir.

m) Raporlar, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın çalışma usul ve esasları hakkındaki düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde düzenlenmelidir.

n) Gerek denetim gerekse raporlama esnasında; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yayınlanan Teftiş ve Denetim Rehberi, talimat ve genelgeler ile bu rehberde belirtilen diğer hususlara riayet edilmelidir.